Reingresos hospitalarios en cardiología: Risk Score Card

Toda la parte de Python del caso, corregida y explicada paso a paso.

Datos: base de datos MySQL `dm_cardiologia`, con 15.038 admisiones de 11.796 pacientes en el servicio de cardiología entre abril de 2022 y marzo de 2024. Son 5 tablas, todas con **una fila por admisión**: `admisiones`, `pacientes`, `factores_riesgo`, `pruebas_laboratorio` y `diagnosticos`.

La idea del proyecto

Un **reingreso** es que un paciente que ya recibió el alta vuelva a ingresar. Los reingresos son caros para el hospital y suelen indicar que el paciente se fue a casa antes de tiempo o sin el seguimiento adecuado.

El objetivo es construir un **Risk Score Card (RSC)**: una tabla de puntos que, en el momento del alta, asigne a cada paciente una nota de **0 a 10** según su riesgo de reingresar. Así el equipo médico puede reforzar el seguimiento de los pacientes con nota alta.

El método es el clásico de *scorecard*, sencillo y explicable:

1. Se elige qué variables están más relacionadas con el reingreso (pruebas estadísticas).
2. Se convierten todas en categorías (las continuas, por tramos).
3. Se calcula la **penetración**: el % de reingresos en cada categoría. Esa penetración son los **puntos**.
4. La nota de un paciente es la suma de los puntos de sus categorías, reescalada de 0 a 10.

Qué reúne este notebook

Notebook original	Dónde está ahora
`01_Carga_e_integracion_de_datos.ipynb`	Pasos 1 y 2: conexión, carga e integración
`02_Calidad_y_EDA.ipynb`	Pasos 3 y 4: calidad del dato y EDA
`03_Minicubo_y_RSC.ipynb`	Pasos 5 a 9: variable objetivo, selección de variables, minicubo, scorecard y validación
`Produccion.ipynb`	Paso 10: script de producción

Se conserva todo el análisis original. Donde había un error se explica qué fallaba y cómo se corrige (**Corrección**). Lo que se añade aparece como **Mejora**.

Errores encontrados y corregidos

#	Dónde	Qué fallaba	Consecuencia	Corrección
1	01 y Producción	**La contraseña de MySQL está escrita en el código**, dos veces en 01	Cualquiera que vea el notebook (GitHub, portfolio) tiene la contraseña	Se pide con `getpass` o se lee de una variable de entorno. **Cambia esa contraseña en MySQL si los notebooks se han publicado**
2	01, 02 y 03	Rutas absolutas a tu Escritorio (`C:/Users/<tu usuario>/Desktop/df.pickle`)	No funciona en otro ordenador y muestra tu usuario	Todo en un notebook; si hace falta caché, ruta relativa
3	02	No se detectaron los **1.238 episodios duplicados** (mismo paciente con las mismas fechas de ingreso y alta: 1.271 filas sobrantes)	Cada copia cuenta como un "reingreso" del mismo día. La tasa de reingreso del modelo sube del 14,8 % al 23,1 %	Se deja un registro por episodio
4	02	No se comprobaron otras incoherencias (contadas ya sin duplicados): 24 pacientes con dos géneros, 2 fallecidos que vuelven a ingresar, 90 ingresos que empiezan antes del alta anterior, 2.179 admisiones con ICFEr e ICFEn a la vez	Datos clínicamente imposibles que entran en el modelo sin avisar	Se documentan y se tratan
5	03	El reingreso es **cualquier ingreso posterior**, aunque sea 2 años después, y no se controla que los últimos ingresos no tienen "futuro" observable	Mezcla reingresos evitables con ingresos nuevos sin relación. Los ingresos de los últimos meses parecen "sin reingreso" porque no ha dado tiempo	Se usa el indicador estándar, **reingreso a 30 días**, y se excluyen las altas sin 30 días de seguimiento. La ventana es un parámetro: con `None` se recupera la definición original
6	03	**El scoring nunca suma los puntos de edad ni de las estancias.** La función pregunta `if "edad_disc" in registro` , pero esas columnas solo existen en `disc_df` , no en `risk` ni en Producción. Además, aunque existieran, son intervalos de `pd.cut` , no texto, y la comparación con `"(0, 10]"` nunca sería cierta	La nota se calcula solo con 9 de las 12 variables. Se ve en el rango que sale, 84-457, que es exactamente la suma de los mínimos y	La función discretiza ella misma y busca los puntos en la tabla

#	Dónde	Qué fallaba	Consecuencia	Corrección
			máximos de las 9 binarias	
7	03 y Producción	Escala 0-10 con el mínimo y máximo **de los datos de esa ejecución** (el texto decía "el que se puede conseguir con nuestra tabla")	En producción, la nota de un paciente cambia según qué otros pacientes entren en la carga	Mínimo y máximo **teóricos** de la scorecard, fijos
8	03	`astype('int')` **trunca**: 8,88 pasa a 8 y 9,99 a 9	Solo la puntuación máxima posible llega a 10	Se redondea
9	03	"Las 3 continuas más significativas" se tomaban con `significativas_con[:3]`, que son las 3 primeras **por orden de columna**	Se eligieron edad y estancias sin comprobar que fueran las mejores	Se ordenan por p-valor
10	03	Las variables se eligen y los puntos se calculan con **todos** los datos, y con esos mismos datos se comprueba que funciona	No hay forma de saber si el modelo funciona con pacientes nuevos	Se separa un periodo de **prueba** (desde julio de 2023) y se mide el AUC
11	03	El ranking de chi-cuadrado incluía la propia variable objetivo (por eso se empezaba en `[1:10]`)	Funciona, pero es frágil	Se excluye explícitamente
12	03	`insuficiencia_cardiaca`, `icfer` e `icfen` puntúan por separado, y clínicamente son la misma enfermedad y sus dos tipos	En datos reales, un paciente con IC sumaría puntos hasta 3 veces por lo mismo. En estos datos apenas están relacionadas (correlación 0,28)	Se comprueba y se explica
13	03	Celdas ejecutadas fuera de orden (contadores 43, 76, 77, 78, 79, 44…)	La tabla `rsc` guardada con la columna `puntos` es el minicubo ancho, no la tabla de puntos	Se ejecuta de arriba abajo; los puntos salen del minicubo
14	03 y Producción	La función de scoring se escribió a mano (con la IA) copiando números	Si cambian los datos, hay que reescribirla; un número	La tabla de puntos se genera y se guarda en un archivo que Producción lee

#	Dónde	Qué fallaba	Consecuencia	Corrección
			mal copiado no se detecta	
15	Producción	No eliminaba duplicados y ordenaba sin desempatar	Mismo problema que el error 3; con dos ingresos en la misma fecha el orden era aleatorio	Igual que en desarrollo
16	01	`con.connect()` abría una conexión nueva en cada lectura y no la cerraba	Conexiones abiertas de más	Un solo bloque `with engine.connect()`
17	Todos	`sys.executable` muestra la ruta de tu usuario de Windows	Dato personal en un portfolio	Se elimina

Cómo usar este notebook

1. Ten el servidor MySQL arrancado con la base `dm_cardiologia` cargada (con tu dump `BD_Cardiologia_Dump.sql`).
2. Ejecuta **Kernel → Restart & Run All**. Al llegar a la conexión te pedirá la contraseña de MySQL, que no queda guardada en ningún sitio.
3. Librerías: `pandas`, `numpy`, `matplotlib`, `seaborn`, `scipy`, `scikit-learn`, `sqlalchemy`, `pymysql`.

Este notebook se ha ejecutado contra **una copia SQLite generada a partir de tu dump**, con las mismas tablas y los mismos datos. El código es el mismo para MySQL y para SQLite: solo cambia la dirección de conexión (paso 1).

1. Preparación y conexión

Corrección (error 1): la contraseña no se escribe en el código. En el original aparecía dos veces en 01 (en la variable `contrasena` y otra vez dentro de la cadena de conexión) y otra en Producción. Un notebook se comparte, se sube a GitHub y se imprime: cualquier contraseña escrita en él deja de ser secreta.

La conexión se resuelve así:

- Si existe la variable de entorno `URL_BD_CARDIOLOGIA`, se usa. Es lo habitual en producción: el servidor tiene la dirección configurada y el código no la conoce.
- Si no existe, se monta la dirección de MySQL. La contraseña se toma de la variable de entorno `MYSQL_PASSWORD` y, si tampoco está definida, se pide con `getpass`, que la lee sin mostrarla en pantalla ni guardarla en el notebook.

`quote_plus` codifica caracteres especiales de la contraseña (`@`, `/`, `:`...), que si no romperían la dirección de conexión.

In [1]:
```
import os
from getpass import getpass
from pathlib import Path
from urllib.parse import quote_plus

import json
import matplotlib.pyplot as plt
import numpy as np
import pandas as pd
import seaborn as sns
from scipy.stats import chi2_contingency, ttest_ind
from sklearn.metrics import roc_auc_score
from sqlalchemy import create_engine, inspect

pd.set_option('display.max_columns', 60)
pd.set_option('display.width', 200)

URL_BD = os.environ.get('URL_BD_CARDIOLOGIA')
if URL_BD is None:
    usuario = 'root'
    host = 'localhost'
    puerto = 3306
    base_datos = 'dm_cardiologia'
    # La contraseña se lee de la variable de entorno MYSQL_PASSWORD; si n
    contrasena = os.environ.get('MYSQL_PASSWORD') or getpass('Contraseña
    URL_BD = f'mysql+pymysql://{usuario}:{quote_plus(contrasena)}@{host}:

engine = create_engine(URL_BD)
print('Conectado a:', engine.dialect.name)
```

```
Conectado a: mysql
```

`create_engine` no abre todavía ninguna conexión: crea el "motor", que las abrirá cuando haga falta.

Si no supiéramos qué tablas contiene la base de datos, podríamos verlo así:

In [2]:
```
inspector = inspect(engine)
print('Tablas en la base de datos:')
for tabla in inspector.get_table_names():
    print(' ', tabla)
```

```
Tablas en la base de datos:
  admisiones
  diagnosticos
  factores_riesgo
  pacientes
  pruebas_laboratorio
```

2. Carga e integración (`01_Carga_e_integracion`)

2.1 Carga

Corrección (error 16): el original hacía `pd.read_sql(..., con.connect())` en cada lectura, que abre una conexión nueva cada vez sin cerrarla. Con `with`

`engine.connect() as conexion:` se abre **una** conexión para las 5 lecturas y se cierra sola al salir del bloque, aunque haya un error.

`parse_dates` convierte las fechas al leerlas. En MySQL ya llegan como fecha; en SQLite llegan como texto. Así el resultado es el mismo con las dos bases.

In [3]:
```
TABLAS = ['admisiones', 'diagnosticos', 'factores_riesgo', 'pacientes', '

with engine.connect() as conexion:
    admisiones = pd.read_sql('SELECT * FROM admisiones', conexion, parse_
    diagnosticos = pd.read_sql('SELECT * FROM diagnosticos', conexion)
    factores_riesgo = pd.read_sql('SELECT * FROM factores_riesgo', conexi
    pacientes = pd.read_sql('SELECT * FROM pacientes', conexion)
    pruebas_laboratorio = pd.read_sql('SELECT * FROM pruebas_laboratorio'

# Comprobamos que se han cargado bien los datos
for nombre, tabla in zip(TABLAS, [admisiones, diagnosticos, factores_ries
    print(f'{nombre:20s} {tabla.shape}')
```

```
admisiones           (15038, 8)
diagnosticos         (15038, 29)
factores_riesgo      (15038, 9)
pacientes            (15038, 5)
pruebas_laboratorio  (15038, 10)
```

Las 5 tablas tienen 15.038 filas: **una por admisión**. Ojo con el nombre engañoso: `pacientes` también tiene una fila por admisión (un paciente que ingresa 3 veces aparece 3 veces).

2.2 Integración

Se unen las tablas por `id_admision` siguiendo el modelo relacional. Antes de unir, la **Mejora** es comprobar que las claves son únicas y que el `id_paciente` coincide en las tablas que lo repiten. Si no fuera así, el `merge` multiplicaría filas o mezclaría pacientes sin avisar.

In [4]:
```
for nombre, tabla in zip(TABLAS, [admisiones, diagnosticos, factores_ries
    assert tabla['id_admision'].is_unique, f'id_admision repetido en {nom

# id_paciente aparece en admisiones, pacientes y factores_riesgo: ¿coinci
comprobar = pacientes[['id_admision', 'id_paciente']].merge(admisiones[['
print('id_paciente distinto entre pacientes y admisiones:', (comprobar['i
comprobar = pacientes[['id_admision', 'id_paciente']].merge(factores_ries
print('id_paciente distinto entre pacientes y factores_riesgo:', (comprob
```

```
id_paciente distinto entre pacientes y admisiones: 0
id_paciente distinto entre pacientes y factores_riesgo: 0
```

Todo cuadra: las claves son únicas y el paciente es el mismo en todas las tablas. Por eso se puede quitar `id_paciente` de `admisiones` antes de unir (si no, aparecería dos veces, como `id_paciente_x` e `id_paciente_y`).

In [5]:
```
# Paso 1: pacientes + admisiones (FK: id_admision)
df = pacientes.merge(admisiones.drop(columns=['id_paciente']), on='id_adm
print('Paso 1:', df.shape)
```

```
# Paso 2: + factores_riesgo (FK: id_admision, id_paciente)
df = df.merge(factores_riesgo, on=['id_admision', 'id_paciente'], how='le
print('Paso 2:', df.shape)

# Paso 3: + pruebas_laboratorio (FK: id_admision)
df = df.merge(pruebas_laboratorio, on='id_admision', how='left')
print('Paso 3:', df.shape)

# Paso 4: + diagnosticos (FK: id_admision)
df = df.merge(diagnosticos, on='id_admision', how='left')
print('Paso 4:', df.shape)
```

```
Paso 1: (15038, 11)
Paso 2: (15038, 18)
Paso 3: (15038, 27)
Paso 4: (15038, 55)
```

El número de filas se mantiene en 15.038 en cada paso (no se duplica nada) y las columnas se van sumando hasta 55.

Corrección (error 2): el original guardaba aquí un caché con `df.to_pickle('C:/Users/<tu usuario>/Desktop/df.pickle')` para pasarlo al notebook 02. Al estar todo en un notebook ya no hace falta. Si quisieras separarlo otra vez, usa una ruta **relativa** a la carpeta del proyecto, por ejemplo `df.to_pickle('datos/df.pickle')`, para que funcione en cualquier ordenador.

3. Calidad del dato (`02_Calidad_y_EDA`)

3.1 Visión general

In [6]:
```
# .T (traspuesta): con 55 columnas se lee mejor en vertical, una fila por
df.head().T
```

Out[6]:

	0	1	2	3	4
id_admision	1	2	3	4	5
id_paciente	234735	234696	234882	234635	234486
edad	81	65	53	67	60
genero	H	H	H	M	M
rural	R	R	U	U	U
fecha_admision	2022-04-01 00:00:00	2022-04-01 00:00:00	2022-04-01 00:00:00	2022-04-01 00:00:00	2022-04-01 00:00:00
fecha_alta	2022-04-03 00:00:00	2022-04-05 00:00:00	2022-04-03 00:00:00	2022-04-08 00:00:00	2022-04-23 00:00:00
tipo_admision	Urgencias	Urgencias	Urgencias	Urgencias	Urgencias
duracion_estancia	3	5	3	8	23
duracion_estancia_ci	2	2	3	6	9
resultado	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta
tabaquismo	0	0	0	0	0
alcohol	0	1	0	0	0
dm	0	0	0	0	0
hta	0	1	0	1	1
eac	0	1	1	1	0
cardiomiopatia_previa	0	0	1	0	0
erc	0	0	1	0	1
hb	9.5	13.7	10.6	12.8	13.6
leucocitos	16.1	9.0	14.7	9.9	9.1
plaquetas	337.0	149.0	329.0	286.0	26.0
glucosa	80.0	112.0	187.0	130.0	144.0
urea	34.0	18.0	93.0	27.0	55.0
creatinina	0.9	0.9	2.3	0.6	1.25
bnp	1880.0	NaN	210.0	NaN	1840.0
enzimas_elevadas	1	0	0	0	0
fe	35.0	42.0	NaN	42.0	16.0
anemia_severa	0	0	0	0	0
anemia	1	0	0	0	0
angina_estable	0	0	0	0	0
sca	1	0	1	1	0
iamcest	0	1	0	0	0

	0	1	2	3	4
dolor_toracico	0	0	0	0	0
insuficiencia_cardiaca	0	0	1	0	0
icfer	0	0	1	0	0
icfen	0	0	1	0	0
valvular_cardiaca	0	0	0	0	0
bavc	0	0	0	0	0
sse	0	0	0	0	0
lra	0	0	1	0	0
acv_infarto	0	0	0	0	0
acv_hemorragia	0	0	0	0	0
fa	0	0	0	0	0
tv	0	1	0	0	0
tsvp	0	0	0	0	0
cardiopatia_congenita	0	0	0	0	0
itu	0	0	0	0	0
sincope_neurocardiogenico	0	0	0	0	0
hipotension_ortostatica	0	0	0	0	0
endocarditis_infecciosa	0	0	0	0	0
tvp	0	0	0	0	0
shock_cardiogenico	0	0	0	0	0
shock	0	0	0	0	0
embolia_pulmonar	0	0	0	0	0
infeccion_pulmonar	0	0	0	0	0

In [7]:
```
df.describe().T
```

Out[7]:

	count	mean	min	25%	50%
id_admision	15038.0	7680.150485	1.0	3809.25	7674.
id_paciente	15038.0	407953.510706	506.0	277004.75	403064.
edad	15038.0	61.363612	4.0	54.0	62.
fecha_admision	15038	2023-04-11 18:15:56.616571	2022-04-01 00:00:00	2022-10-12 06:00:00	2023-04-1 00:00:0
fecha_alta	15038	2023-04-17 04:26:46.809416	2022-04-02 00:00:00	2022-10-18 00:00:00	2023-04-2 00:00:0
duracion_estancia	15038.0	6.41455	1.0	3.0	5.
duracion_estancia_ci	15038.0	3.807155	0.0	1.0	3.
tabaquismo	15038.0	0.051137	0.0	0.0	0.
alcohol	15038.0	0.065567	0.0	0.0	0.
dm	15038.0	0.30004	0.0	0.0	0.
hta	15038.0	0.485836	0.0	0.0	0.
eac	15038.0	0.669304	0.0	0.0	1.
cardiomiopatia_previa	15038.0	0.319989	0.0	0.0	0.
erc	15038.0	0.311478	0.0	0.0	0.
hb	14796.0	12.23638	3.0	10.7	12.
leucocitos	14764.0	11.521909	0.1	7.9	10
plaquetas	14761.0	238.462337	0.58	171.0	225.
glucosa	14130.0	163.180042	17.0	106.0	136.
urea	14807.0	49.760087	0.1	25.0	35.
creatinina	14798.0	1.340797	0.065	0.76	1.
bnp	6281.0	820.041586	4.0	121.0	471.
enzimas_elevadas	15038.0	0.197899	0.0	0.0	0.
fe	13506.0	43.447683	14.0	32.0	42.
anemia_severa	15038.0	0.018952	0.0	0.0	0.
anemia	15038.0	0.174624	0.0	0.0	0.
angina_estable	15038.0	0.081726	0.0	0.0	0.
sca	15038.0	0.288536	0.0	0.0	0.
iamcest	15038.0	0.292326	0.0	0.0	0.
dolor_toracico	15038.0	0.025602	0.0	0.0	0.
insuficiencia_cardiaca	15038.0	0.332957	0.0	0.0	0.
icfer	15038.0	0.321519	0.0	0.0	0.
icfen	15038.0	0.317196	0.0	0.0	0.

	count	mean	min	25%	50%
valvular_cardiaca	15038.0	0.035444	0.0	0.0	0.
bavc	15038.0	0.026267	0.0	0.0	0.
sse	15038.0	0.007049	0.0	0.0	0.
lra	15038.0	0.304761	0.0	0.0	0.
acv_infarto	15038.0	0.029459	0.0	0.0	0.
acv_hemorragia	15038.0	0.00399	0.0	0.0	0.
fa	15038.0	0.051137	0.0	0.0	0.
tv	15038.0	0.032983	0.0	0.0	0.
tsvp	15038.0	0.007647	0.0	0.0	0.
cardiopatia_congenita	15038.0	0.010839	0.0	0.0	0.
itu	15038.0	0.062176	0.0	0.0	0.
sincope_neurocardiogenico	15038.0	0.008179	0.0	0.0	0.
hipotension_ortostatica	15038.0	0.007913	0.0	0.0	0.
endocarditis_infecciosa	15038.0	0.001862	0.0	0.0	0.
tvp	15038.0	0.013233	0.0	0.0	0.
shock_cardiogenico	15038.0	0.059981	0.0	0.0	0.
shock	15038.0	0.047147	0.0	0.0	0.
embolia_pulmonar	15038.0	0.01576	0.0	0.0	0.
infeccion_pulmonar	15038.0	0.021678	0.0	0.0	0.

In [8]:
```
df.info()
```

```
<class 'pandas.DataFrame'>
RangeIndex: 15038 entries, 0 to 15037
Data columns (total 55 columns):
 #   Column                       Non-Null Count  Dtype
---  ------                       --------------  -----
 0   id_admision                  15038 non-null  int64
 1   id_paciente                  15038 non-null  int64
 2   edad                         15038 non-null  int64
 3   genero                       15038 non-null  str
 4   rural                        15038 non-null  str
 5   fecha_admision               15038 non-null  datetime64[us]
 6   fecha_alta                   15038 non-null  datetime64[us]
 7   tipo_admision                15038 non-null  str
 8   duracion_estancia            15038 non-null  int64
 9   duracion_estancia_ci         15038 non-null  int64
 10  resultado                    15038 non-null  str
 11  tabaquismo                   15038 non-null  int64
 12  alcohol                      15038 non-null  int64
 13  dm                           15038 non-null  int64
 14  hta                          15038 non-null  int64
 15  eac                          15038 non-null  int64
 16  cardiomiopatia_previa        15038 non-null  int64
 17  erc                          15038 non-null  int64
 18  hb                           14796 non-null  float64
 19  leucocitos                   14764 non-null  float64
 20  plaquetas                    14761 non-null  float64
 21  glucosa                      14130 non-null  float64
 22  urea                         14807 non-null  float64
 23  creatinina                   14798 non-null  float64
 24  bnp                          6281 non-null   float64
 25  enzimas_elevadas             15038 non-null  int64
 26  fe                           13506 non-null  float64
 27  anemia_severa                15038 non-null  int64
 28  anemia                       15038 non-null  int64
 29  angina_estable               15038 non-null  int64
 30  sca                          15038 non-null  int64
 31  iamcest                      15038 non-null  int64
 32  dolor_toracico               15038 non-null  int64
 33  insuficiencia_cardiaca       15038 non-null  int64
 34  icfer                        15038 non-null  int64
 35  icfen                        15038 non-null  int64
 36  valvular_cardiaca            15038 non-null  int64
 37  bavc                         15038 non-null  int64
 38  sse                          15038 non-null  int64
 39  lra                          15038 non-null  int64
 40  acv_infarto                  15038 non-null  int64
 41  acv_hemorragia               15038 non-null  int64
 42  fa                           15038 non-null  int64
 43  tv                           15038 non-null  int64
 44  tsvp                         15038 non-null  int64
 45  cardiopatia_congenita        15038 non-null  int64
 46  itu                          15038 non-null  int64
 47  sincope_neurocardiogenico    15038 non-null  int64
 48  hipotension_ortostatica      15038 non-null  int64
 49  endocarditis_infecciosa      15038 non-null  int64
 50  tvp                          15038 non-null  int64
 51  shock_cardiogenico           15038 non-null  int64
 52  shock                        15038 non-null  int64
 53  embolia_pulmonar             15038 non-null  int64
 54  infeccion_pulmonar           15038 non-null  int64
```

```
dtypes: datetime64[us](2), float64(8), int64(41), str(4)
memory usage: 6.3 MB
```

3.2 Nulos

In [9]:
```
nulos = df.isna().sum()
nulos = nulos[nulos > 0].sort_values(ascending=False)
pd.DataFrame({'nulos': nulos, '%': (nulos / len(df) * 100).round(1)})
```

Out[9]:

	nulos	%
bnp	8757	58.2
fe	1532	10.2
glucosa	908	6.0
plaquetas	277	1.8
leucocitos	274	1.8
hb	242	1.6
creatinina	240	1.6
urea	231	1.5

Solo tienen nulos las pruebas de laboratorio. Es lógico: no a todos los pacientes se les hacen todas las pruebas. El BNP (péptido natriurético, un marcador de insuficiencia cardiaca) falta en el 58 % de las admisiones porque solo se pide cuando se sospecha IC.

En un *scorecard* los nulos **no se imputan**: "no se le hizo la prueba" es información en sí misma. Se tratan como una categoría más, "Sin dato" (paso 7).

3.3 Inconsistencias

La fecha de alta no debería ser anterior a la de admisión:

In [10]:
```
df.loc[df.fecha_alta < df.fecha_admision]
```

Out[10]:

id_admision	id_paciente	edad	genero	rural	fecha_admision	fecha_alta	tipo_ad

La estancia en cuidados intensivos (`duracion_estancia_ci`) no debería ser mayor que la estancia total, porque la segunda incluye a la primera:

In [11]:
```
df.loc[df.duracion_estancia_ci > df.duracion_estancia, 'id_admision':'dur
```

Out[11]:

	id_admision	id_paciente	edad	genero	rural	fecha_admision	fecha_alta	t
299	315	250611	57	M	U	2022-04-24	2022-04-25	
587	603	169721	58	H	U	2022-05-06	2022-05-09	
1065	1082	276487	46	H	R	2022-05-31	2022-06-04	
1108	1125	278565	66	H	U	2022-06-02	2022-06-06	
1253	1270	35750	41	H	R	2022-06-08	2022-06-08	
...	...	...	...	...	...	...	...	
13753	14103	634612	60	M	U	2024-01-28	2024-01-28	
14549	15172	683978	59	H	R	2024-03-07	2024-03-19	
14593	15310	676533	74	H	R	2024-03-13	2024-03-15	
14715	15433	688011	57	M	U	2024-03-18	2024-03-19	
14917	15637	692217	51	M	U	2024-03-26	2024-03-29	

68 rows × 10 columns

In [12]:
```
# Corregir: la estancia en CI no puede superar la estancia total
df.loc[df['duracion_estancia_ci'] > df['duracion_estancia'], 'duracion_es

# Comprobamos que se ha corregido
df.loc[df.duracion_estancia_ci > df.duracion_estancia, 'id_admision':'dur
```

Out[12]:

id_admision	id_paciente	edad	genero	rural	fecha_admision	fecha_alta	tipo_ad

Se corrigen 68 casos, acotando la estancia en CI a la estancia total.

Mejora: ¿cuadra la estancia con las fechas?

In [13]:
```
dias_entre_fechas = (df['fecha_alta'] - df['fecha_admision']).dt.days
diferencia = df['duracion_estancia'] - dias_entre_fechas
diferencia.value_counts()
```

Out[13]:
```
1    14893
0      145
Name: count, dtype: int64
```

En el 99 % de los casos `duracion_estancia` = días entre fechas + 1: cuenta **el día de ingreso y el de alta**. Un paciente que entra y sale el mismo día tiene estancia 1, no 0. En los otros 145 casos coincide exactamente con la resta de fechas. Son dos criterios mezclados, pero la diferencia es de un día, así que no

afecta al análisis. Conviene saberlo si en el dashboard se recalcula la estancia a partir de las fechas.

3.4 Mejora: episodios duplicados (error 3)

Si un mismo paciente tiene dos admisiones con **la misma fecha de ingreso y la misma fecha de alta**, es el mismo episodio registrado dos veces:

In [14]:
```
clave_episodio = ['id_paciente', 'fecha_admision', 'fecha_alta']
en_duplicado = df.duplicated(clave_episodio, keep=False)

print('Episodios con más de un registro:', df[en_duplicado].groupby(clave
print('Filas implicadas:', en_duplicado.sum())
print('Filas sobrantes (las que habría que quitar):', df.duplicated(clave

df[en_duplicado].sort_values(clave_episodio + ['id_admision'])[
    ['id_admision', 'id_paciente', 'fecha_admision', 'fecha_alta', 'tipo_
     'insuficiencia_cardiaca', 'icfer', 'icfen', 'erc', 'dm', 'sca']].hea
```

```
Episodios con más de un registro: 1238
Filas implicadas: 2509
Filas sobrantes (las que habría que quitar): 1271
```

Out[14]:

	id_admision	id_paciente	fecha_admision	fecha_alta	tipo_admision	resu
12549	12720	989	2023-05-12	2023-05-14	Urgencias	
12550	12721	989	2023-05-12	2023-05-14	Urgencias	
11363	11531	4973	2023-10-17	2023-10-22	Urgencias	AltaNoM
11367	11535	4973	2023-10-17	2023-10-22	Urgencias	AltaNoM
5009	5154	9039	2022-12-14	2022-12-17	Urgencias	
5023	5168	9039	2022-12-14	2022-12-17	Consulta	
6166	6316	20445	2023-01-29	2023-02-26	Urgencias	
6167	6317	20445	2023-01-29	2023-02-26	Urgencias	

In [15]:
```
# ¿En qué columnas se diferencian las copias de un mismo episodio?
columnas_distintas = (df[en_duplicado].groupby(clave_episodio)[[c for c i
                      .nunique().gt(1).sum().sort_values(ascending=False)
columnas_distintas.head(12)
```

Out[15]:
```
insuficiencia_cardiaca    801
icfer                     783
cardiomiopatia_previa     769
icfen                     757
lra                       754
erc                       754
iamcest                   730
dm                        724
sca                       720
duracion_estancia_ci      232
tipo_admision             127
rural                      72
dtype: int64
```

Hay 1.238 episodios duplicados (1.271 filas sobrantes, porque algunos episodios están 3 o 4 veces). Además, las copias **no son idénticas**: se diferencian sobre todo en los 9 diagnósticos que luego resultarán ser los más relacionados con el reingreso (insuficiencia cardiaca, ICFEr, ICFEn, cardiomiopatía, ERC, LRA, DM, IAMCEST, SCA).

Esto importa mucho para el análisis. Con la definición original, la segunda copia de un episodio cuenta como **reingreso del mismo día**, así que la primera copia queda marcada como "genera reingreso". Las copias inflan la tasa de reingreso y la relación de esos diagnósticos con el reingreso (se cuantifica en el paso 5).

Decisión: se conserva **un registro por episodio**, el de menor `id_admision` (el primero que se registró). No hay forma de saber cuál de las copias es la correcta. Otra opción razonable sería unir los diagnósticos de todas las copias (un diagnóstico está presente si aparece en cualquiera de ellas).

In [16]:
```
df = df.sort_values(['id_paciente', 'fecha_admision', 'id_admision'])
df = df.drop_duplicates(clave_episodio, keep='first').reset_index(drop=Tr
print('Admisiones tras quitar duplicados:', len(df))
```

```
Admisiones tras quitar duplicados: 13767
```

3.5 Mejora: otras incoherencias (error 4)

In [17]:
```
# Pacientes con más de un género registrado
genero_por_paciente = df.groupby('id_paciente')['genero'].nunique()
print('Pacientes con dos géneros distintos:', (genero_por_paciente > 1).s

# Fallecidos que vuelven a ingresar después
siguiente_ingreso = df.groupby('id_paciente')['fecha_admision'].shift(-1)
print('Defunciones con un ingreso posterior:', ((df['resultado'] == 'Defu

# Ingresos que empiezan antes del alta del ingreso anterior (solapados)
alta_anterior = df.groupby('id_paciente')['fecha_alta'].shift(1)
print('Ingresos que empiezan antes del alta anterior:', (df['fecha_admisi

# Insuficiencia cardiaca con FE reducida y con FE normal a la vez
print('Admisiones con ICFEr e ICFEn a la vez:', ((df['icfer'] == 1) & (df
print('Admisiones con ICFEr o ICFEn pero sin insuficiencia cardiaca:',
      (((df['icfer'] == 1) | (df['icfen'] == 1)) & (df['insuficiencia_car
```

```
Pacientes con dos géneros distintos: 24
Defunciones con un ingreso posterior: 2
Ingresos que empiezan antes del alta anterior: 90
Admisiones con ICFEr e ICFEn a la vez: 2179
Admisiones con ICFEr o ICFEn pero sin insuficiencia cardiaca: 3571
```

Ninguna de estas situaciones es posible en la realidad:

- Un paciente no cambia de género entre dos ingresos (24 casos; 27 antes de quitar duplicados): es un error de registro.
- Un fallecido no vuelve a ingresar (2 casos).
- Un ingreso no empieza antes de que termine el anterior (90 casos). Pueden ser traslados entre servicios registrados como ingresos nuevos. **No se cuentan como reingreso**, porque el paciente no llegó a irse a casa.
- La insuficiencia cardiaca es con fracción de eyección **reducida** (ICFEr) o **normal/preservada** (ICFEn), no las dos a la vez. Y tanto la ICFEr como la ICFEn son tipos de insuficiencia cardiaca, así que no deberían aparecer sin ella. Aquí pasa en miles de casos. Es un indicio de que los datos son **sintéticos** (generados para el ejercicio) o de que estas columnas no significan exactamente lo que su nombre indica.

No se elimina nada más (son pocos casos, o no se sabe cuál es el dato bueno), pero en un proyecto real habría que preguntar a quien gestiona el dato.

4. EDA (`02_Calidad_y_EDA`)

4.1 Análisis de niveles

Se comprueba si los identificadores se repiten.

In [18]:
```
# ¿Puede repetirse el código de admisión?
df.id_admision.value_counts()
```

Out[18]:
```
id_admision
15196    1
93       1
3526     1
15111    1
12720    1
        ..
8284     1
10642    1
8693     1
10478    1
6913     1
Name: count, Length: 13767, dtype: int64
```

In [19]:
```
# ¿Puede repetirse el código de paciente? (si sí, hay pacientes con vario
df.id_paciente.value_counts()
```

Out[19]:
```
id_paciente
273016     14
256628     12
325715     11
211418      9
415865      8
           ..
4888078     1
4888286     1
4888926     1
5711587     1
6408503     1
Name: count, Length: 11796, dtype: int64
```

In [20]:
```
# Pacientes con más de un ingreso
df[df.id_paciente.duplicated()].id_paciente.nunique()
```

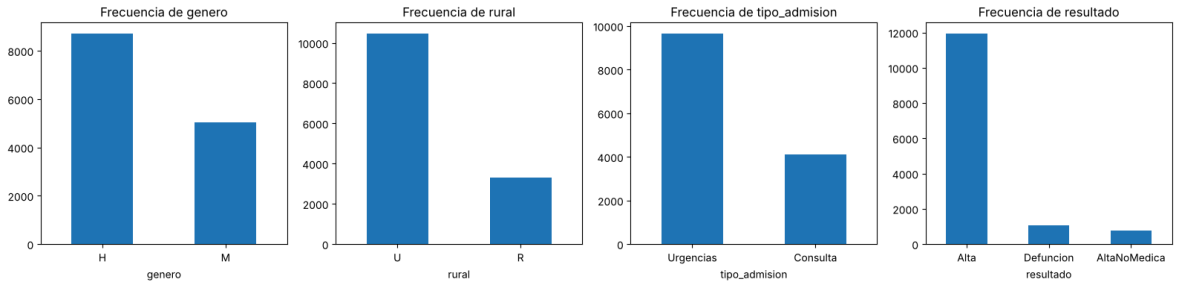
Out[20]:
```
1497
```

`id_admision` es único (es la clave) y `id_paciente` se repite: hay pacientes con hasta 14 ingresos. Tras quitar duplicados, **1.497 pacientes** tienen más de un ingreso. En el original salían 2.426, porque contaba como "segundo ingreso" las copias duplicadas.

4.2 Variables categóricas

In [21]:
```
# Variables de texto. Se detectan así para que funcione igual en pandas 2
categoricas_texto = [c for c in df.columns
                     if not pd.api.types.is_numeric_dtype(df[c]) and not

fig, ejes = plt.subplots(1, len(categoricas_texto), figsize=(16, 4))
for eje, variable in zip(ejes, categoricas_texto):
    df[variable].value_counts().plot.bar(ax=eje, rot=0)
    eje.set_title(f'Frecuencia de {variable}')
plt.tight_layout()
plt.show()
```



Mejora: los 4 gráficos se dibujan en una sola figura (`plt.subplots`) para compararlos de un vistazo. En el original salía uno debajo de otro.

- Hay más hombres (63 %) que mujeres y más población urbana (76 %) que rural.
- 7 de cada 10 ingresos llegan por Urgencias.
- El resultado más frecuente es el alta (87 %); las defunciones son el 7,6 % de las admisiones y el alta no médica (voluntaria) el 5,6 %.

4.3 Variables numéricas

In [22]:
```
# Mejora: se seleccionan por tipo, no por posición (el original usaba df.
df.select_dtypes('number').drop(columns=['id_admision', 'id_paciente']).d
```

Out[22]:

	count	mean	std	min	25%	50%
edad	13767.0	61.343793	13.428563	4.000	54.00	62.0
duracion_estancia	13767.0	6.370378	5.035487	1.000	3.00	5.0
duracion_estancia_ci	13767.0	3.777802	4.028964	0.000	1.00	3.0
tabaquismo	13767.0	0.052880	0.223802	0.000	0.00	0.0
alcohol	13767.0	0.067989	0.251736	0.000	0.00	0.0
dm	13767.0	0.303116	0.459622	0.000	0.00	0.0
hta	13767.0	0.484056	0.499764	0.000	0.00	0.0
eac	13767.0	0.665650	0.471780	0.000	0.00	1.0
cardiomiopatia_previa	13767.0	0.323455	0.467812	0.000	0.00	0.0
erc	13767.0	0.315900	0.464890	0.000	0.00	0.0
hb	13532.0	12.240132	2.320748	3.000	10.70	12.4
leucocitos	13504.0	11.561768	7.243059	0.100	7.90	10.1
plaquetas	13499.0	238.375921	104.234320	0.580	172.00	225.0
glucosa	12905.0	163.437737	84.717946	17.000	106.00	136.0
urea	13542.0	49.917096	42.264211	0.100	25.00	35.0
creatinina	13534.0	1.350969	1.214455	0.065	0.76	1.0
bnp	5632.0	826.673810	1005.104165	4.000	124.75	475.0
enzimas_elevadas	13767.0	0.201278	0.400970	0.000	0.00	0.0
fe	12349.0	43.392129	13.461319	14.000	32.00	42.0
anemia_severa	13767.0	0.018305	0.134056	0.000	0.00	0.0
anemia	13767.0	0.174548	0.379594	0.000	0.00	0.0
angina_estable	13767.0	0.082298	0.274829	0.000	0.00	0.0
sca	13767.0	0.291930	0.454667	0.000	0.00	0.0
iamcest	13767.0	0.294981	0.456051	0.000	0.00	0.0
dolor_toracico	13767.0	0.025714	0.158285	0.000	0.00	0.0
insuficiencia_cardiaca	13767.0	0.337837	0.472990	0.000	0.00	0.0
icfer	13767.0	0.323890	0.467976	0.000	0.00	0.0
icfen	13767.0	0.319096	0.466143	0.000	0.00	0.0
valvular_cardiaca	13767.0	0.036028	0.186367	0.000	0.00	0.0
bavc	13767.0	0.026077	0.159370	0.000	0.00	0.0
sse	13767.0	0.007336	0.085341	0.000	0.00	0.0
lra	13767.0	0.307547	0.461495	0.000	0.00	0.0
acv_infarto	13767.0	0.030653	0.172382	0.000	0.00	0.0
acv_hemorragia	13767.0	0.003922	0.062509	0.000	0.00	0.0

	count	mean	std	min	25%	50%
fa	13767.0	0.052807	0.223657	0.000	0.00	0.0
tv	13767.0	0.033413	0.179720	0.000	0.00	0.0
tsvp	13767.0	0.007627	0.087002	0.000	0.00	0.0
cardiopatia_congenita	13767.0	0.011259	0.105512	0.000	0.00	0.0
itu	13767.0	0.063267	0.243452	0.000	0.00	0.0
sincope_neurocardiogenico	13767.0	0.008353	0.091017	0.000	0.00	0.0
hipotension_ortostatica	13767.0	0.008281	0.090624	0.000	0.00	0.0
endocarditis_infecciosa	13767.0	0.001889	0.043418	0.000	0.00	0.0
tvp	13767.0	0.013438	0.115145	0.000	0.00	0.0
shock_cardiogenico	13767.0	0.062977	0.242930	0.000	0.00	0.0
shock	13767.0	0.050192	0.218350	0.000	0.00	0.0
embolia_pulmonar	13767.0	0.015835	0.124841	0.000	0.00	0.0
infeccion_pulmonar	13767.0	0.022808	0.149297	0.000	0.00	0.0

Lectura:

- Casi todas las variables numéricas son **indicadores 0/1** (factores de riesgo y diagnósticos): su media es directamente el % de admisiones que los tienen. Por ejemplo, la media de `insuficiencia_cardiaca` es la proporción de admisiones con ese diagnóstico.
- **Valores llamativos en laboratorio**: plaquetas con un mínimo de 0,58 (lo normal es 150-400 mil/µL, así que parece un dato en otra unidad), BNP con 83 valores exactamente en 5.000 (el **tope** de medida del análisis) y fracción de eyección con un máximo de exactamente 60 (probablemente se registró "≥ 60 %" como 60). No son errores que haya que corregir, pero sí topes que conviene conocer.

5. Variable objetivo: el reingreso (`03_Minicubo_y_RSC`)

5.1 La definición original

El original marcaba como reingreso **toda admisión que no es la primera del paciente**:

In [23]:
```
# Ordenar por paciente y fecha (con id_admision para desempatar ingresos
df = df.sort_values(['id_paciente', 'fecha_admision', 'id_admision']).res

# Reingreso (definición original): el paciente de esta fila es el mismo q
df['reingreso'] = (df['id_paciente'] == df['id_paciente'].shift(1)).astyp

df[['id_admision', 'id_paciente', 'fecha_admision', 'fecha_alta', 'result
```

Out[23]:

	id_admision	id_paciente	fecha_admision	fecha_alta	resultado	reingreso
0	15196	506	2024-03-07	2024-03-10	Alta	0
1	93	798	2022-04-05	2022-04-06	Alta	0
2	3526	798	2022-05-10	2022-05-11	Alta	1
3	15111	798	2024-03-04	2024-03-09	Alta	1
4	12720	989	2023-05-12	2023-05-14	Alta	0
5	11477	989	2023-10-15	2023-10-17	Alta	1
6	6500	1006	2023-09-02	2023-10-29	Defuncion	0
7	4033	1060	2022-11-01	2022-11-02	Alta	0
8	4386	1196	2022-11-13	2022-11-21	Alta	0
9	8587	1261	2023-05-26	2023-05-28	Alta	0

`shift(1)` desplaza la columna una fila hacia abajo. Así cada fila "ve" el paciente de la fila anterior; si es el mismo, esta admisión es un reingreso. Como los datos están ordenados por paciente y fecha, la primera admisión de cada paciente siempre tiene `reingreso = 0`.

Corrección (error 15): se añade `id_admision` al ordenar. Si un paciente tiene dos ingresos en la misma fecha, sin desempate el orden entre ellos depende de cómo estuvieran los datos al leerlos, y puede cambiar de una ejecución a otra.

In [24]:
```
# ¿Qué porcentaje de admisiones son reingresos?
df.reingreso.mean() * 100
```

Out[24]:
```
np.float64(14.31684462845936)
```

Análisis a nivel de paciente

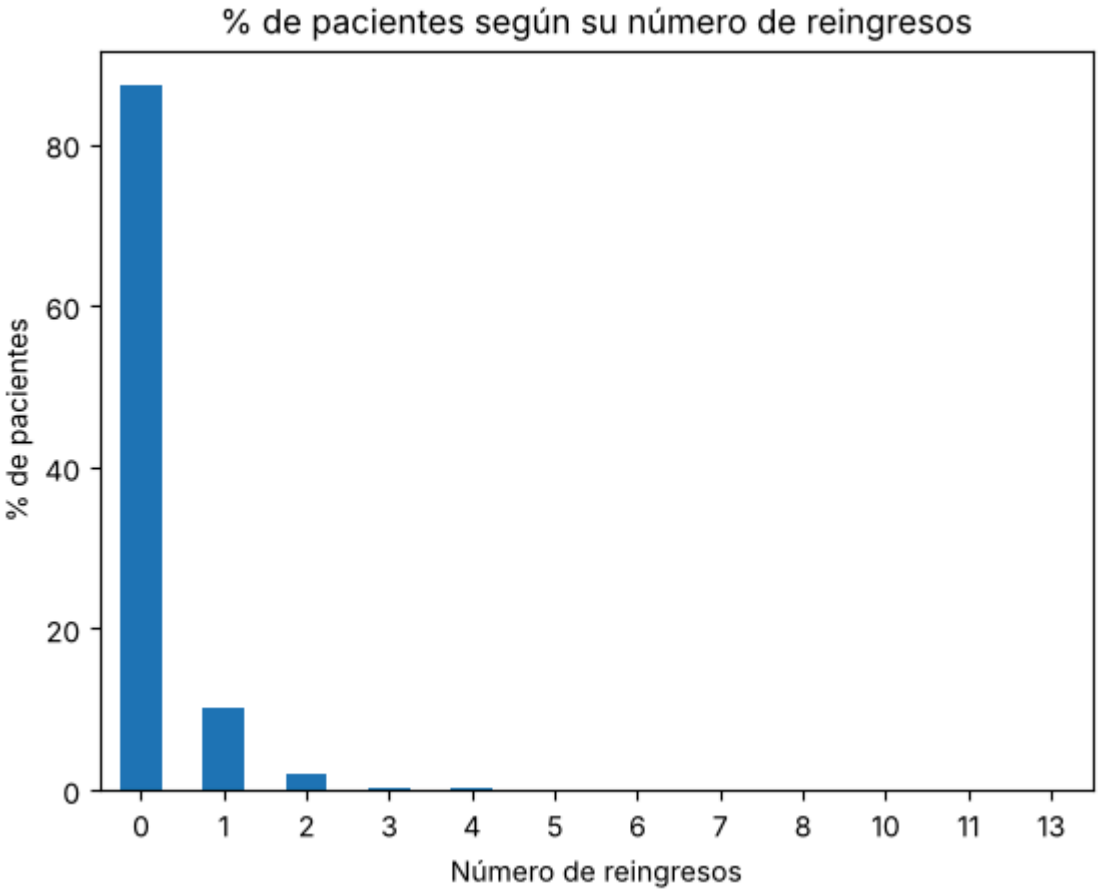
In [25]:
```
reingresos_pacientes = df.groupby('id_paciente').reingreso.sum()
reingresos_pacientes_agr = reingresos_pacientes.value_counts().sort_index
reingresos_pacientes_agr
```

Out[25]:
```
reingreso
0     10299
1      1189
2       224
3        46
4        22
5         7
6         4
7         1
8         1
10        1
11        1
13        1
Name: count, dtype: int64
```

In [26]:
```
# ¿Qué porcentaje de pacientes tiene al menos un reingreso?
(1 - reingresos_pacientes_agr[0] / reingresos_pacientes_agr.sum()) * 100
```

Out[26]:
```
np.float64(12.690742624618512)
```

In [27]:
```
# Distribución de los reingresos (% de pacientes)
reingresos_pacientes_agr_porc = reingresos_pacientes_agr / reingresos_pac
ax = reingresos_pacientes_agr_porc.plot.bar(rot=0, title='% de pacientes
ax.set_xlabel('Número de reingresos')
ax.set_ylabel('% de pacientes')
plt.show()
reingresos_pacientes_agr_porc.round(2)
```



Out[27]:
```
reingreso
0     87.31
1     10.08
2      1.90
3      0.39
4      0.19
5      0.06
6      0.03
7      0.01
8      0.01
10     0.01
11     0.01
13     0.01
Name: count, dtype: float64
```

El 87,3 % de los pacientes no reingresa nunca y el 10,1 % reingresa una vez. Unos pocos acumulan muchos ingresos (hasta 13 reingresos): son crónicos con

descompensaciones frecuentes. En el original salía un 20,6 % de pacientes con algún reingreso; la diferencia son los duplicados.

5.2 Corrección (error 5): ¿cuánto tiempo después?

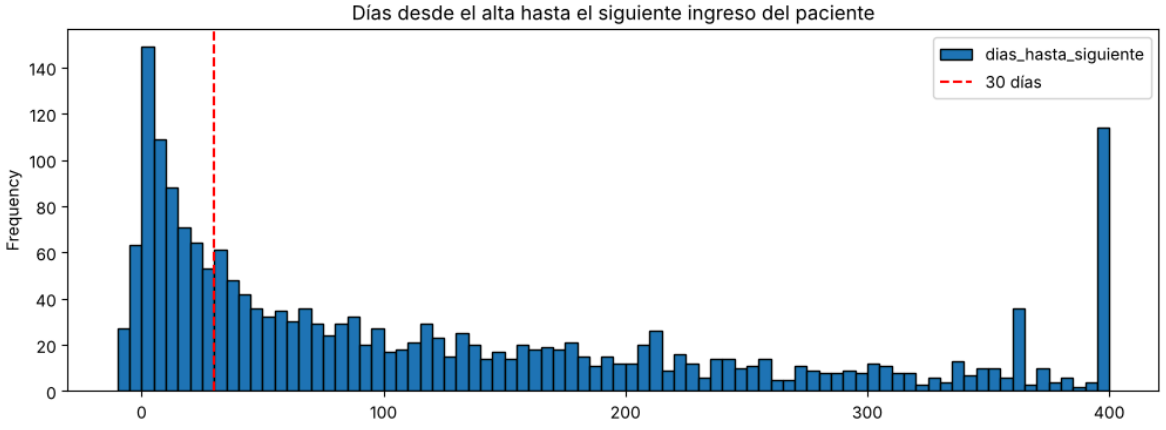
La definición original cuenta como reingreso cualquier ingreso posterior, aunque sea 2 años después. Se mira cuántos días pasan entre el alta y el siguiente ingreso:

In [28]:
```
df['siguiente_ingreso'] = df.groupby('id_paciente')['fecha_admision'].shi
df['dias_hasta_siguiente'] = (df['siguiente_ingreso'] - df['fecha_alta'])

print(df['dias_hasta_siguiente'].describe().round(1))

ax = df['dias_hasta_siguiente'].clip(-10, 400).plot.hist(bins=82, figsize
                                                         title='Días desd
ax.axvline(30, color='red', linestyle='--', label='30 días')
ax.legend()
plt.show()
```

```
count    1971.0
mean      128.8
std       139.0
min       -52.0
25%        19.0
50%        77.0
75%       204.0
max       704.0
Name: dias_hasta_siguiente, dtype: float64
```



La mediana es de **77 días** y una cuarta parte de los siguientes ingresos llega más de 200 días después. Un ingreso a los 600 días casi nunca tiene que ver con cómo se dio el alta anterior.

El indicador estándar en hospitales es el **reingreso a 30 días**: un nuevo ingreso del mismo paciente en los 30 días siguientes al alta. Es el que se usa para medir la calidad asistencial, porque es el que se puede evitar con un mejor alta y seguimiento.

Hay un segundo problema, la **censura por la derecha**: los datos acaban el 31 de marzo de 2024. Un paciente dado de alta el 25 de marzo no ha tenido tiempo de reingresar, y con la definición original aparece como "no genera reingreso" aunque

reingrese el 2 de abril. Hay que excluir del modelo las altas que no tienen el periodo de seguimiento completo.

La ventana se define como parámetro. Con `VENTANA_DIAS = 30` se usa el reingreso a 30 días; con `VENTANA_DIAS = None` se recupera la definición original (cualquier ingreso posterior), por si en el curso se pide así.

In [29]:
```
VENTANA_DIAS = 30                                # None = cualquier ingre
FECHA_FIN_DATOS = df['fecha_admision'].max()     # último día con ingreso

def calcular_genera_reingreso(dias_hasta_siguiente, ventana=VENTANA_DIAS)
    # 1 si el paciente vuelve a ingresar después del alta (dentro de la v
    # dias < 0: el siguiente ingreso empieza antes del alta (solapado): n
    if ventana is None:
        return (dias_hasta_siguiente >= 0).astype(int)
    return ((dias_hasta_siguiente >= 0) & (dias_hasta_siguiente <= ventan

df['genera_reingreso'] = calcular_genera_reingreso(df['dias_hasta_siguien

# ¿Tiene esta alta el seguimiento completo? (si no hay ventana, todas las
if VENTANA_DIAS is None:
    df['seguimiento_completo'] = True
else:
    df['seguimiento_completo'] = df['fecha_alta'] <= FECHA_FIN_DATOS - pd

print('Último ingreso registrado:', FECHA_FIN_DATOS.date())
print('Altas sin seguimiento completo:', (~df['seguimiento_completo']).su
df[['id_admision', 'id_paciente', 'fecha_admision', 'fecha_alta', 'reingr
```

```
Último ingreso registrado: 2024-03-31
Altas sin seguimiento completo: 595
```

Out[29]:

	id_admision	id_paciente	fecha_admision	fecha_alta	reingreso	dias_hasta_siguie
0	15196	506	2024-03-07	2024-03-10	0	
1	93	798	2022-04-05	2022-04-06	0	
2	3526	798	2022-05-10	2022-05-11	1	6
3	15111	798	2024-03-04	2024-03-09	1	
4	12720	989	2023-05-12	2023-05-14	0	1
5	11477	989	2023-10-15	2023-10-17	1	
6	6500	1006	2023-09-02	2023-10-29	0	
7	4033	1060	2022-11-01	2022-11-02	0	
8	4386	1196	2022-11-13	2022-11-21	0	
9	8587	1261	2023-05-26	2023-05-28	0	

Cómo funciona:

- `groupby('id_paciente')['fecha_admision'].shift(-1)` trae a cada fila la fecha del **siguiente** ingreso del **mismo** paciente. Al hacerse dentro del `groupby`, la última admisión de un paciente nunca "ve" la del paciente siguiente: queda `NaT`.
- `dias_hasta_siguiente` son los días entre el alta y ese siguiente ingreso. Las comparaciones con `NaT` / `NaN` dan `False`, así que la última admisión de cada paciente queda con 0.

El original hacía `risk['genera_reingreso'] = risk.reingreso.shift(-1)`, sin `groupby`. Era correcto con su definición, aunque por casualidad: `reingreso` de la fila siguiente solo vale 1 si esa fila es del mismo paciente. Aquí se calcula de forma explícita, que es más fácil de leer y permite añadir la ventana de días.

5.3 Población del modelo

Se quitan dos grupos:

- **Defunciones.** Un paciente que fallece en el ingreso no puede reingresar, por mucho riesgo que tuviera. Si se dejara, sus características (que suelen ser de alto riesgo) aparecerían como "no generan reingreso" y confundirían al modelo. Si interesara la mortalidad, se haría este mismo análisis con la defunción como objetivo.

- **Altas sin seguimiento completo** (censura).

In [30]:
```
risk = df[(df['resultado'] != 'Defuncion') & df['seguimiento_completo']].
print('Admisiones en el modelo:', len(risk))
print(risk['resultado'].value_counts())
print(f"\nTasa de reingreso a {VENTANA_DIAS} días: {risk['genera_reingres
```

```
Admisiones en el modelo: 12156
resultado
Alta            11430
AltaNoMedica      726
Name: count, dtype: int64

Tasa de reingreso a 30 días: 4.48 %
```

Cuánto cambia la definición: se compara la tasa de reingreso del modelo con la definición original (con y sin los duplicados) y con la corregida.

In [31]:
```
# Recalculamos la definición original sobre los datos SIN quitar duplicad
original = pacientes.merge(admisiones.drop(columns=['id_paciente']), on='
original['reingreso'] = (original['id_paciente'] == original['id_paciente
original['genera_reingreso'] = original['reingreso'].shift(-1)
original = original[original['resultado'] != 'Defuncion']

sin_dup = df[df['resultado'] != 'Defuncion']
pd.DataFrame({
    'admisiones': [len(original), len(sin_dup), len(risk)],
    'tasa_reingreso_%': [original['genera_reingreso'].mean() * 100,
                         (sin_dup['dias_hasta_siguiente'] >= 0).mean() *
                         risk['genera_reingreso'].mean() * 100],
}, index=['Original (cualquier ingreso posterior, con duplicados)',
          'Cualquier ingreso posterior, sin duplicados',
          f'Corregida: reingreso a {VENTANA_DIAS} días, sin duplicados ni
```

Out[31]:

	admisiones	tasa_reingreso_%
Original (cualquier ingreso posterior, con duplicados)	13984	23.13
Cualquier ingreso posterior, sin duplicados	12719	14.77
Corregida: reingreso a 30 días, sin duplicados ni censura	12156	4.48

La tasa pasa del **23,1 %** original al **14,8 %** al quitar duplicados y solapes, y al **4,5 %** con el reingreso a 30 días. Es una tasa de reingreso a 30 días baja para cardiología (en la literatura suele estar entre el 10 y el 20 %), pero los datos son los que son. El modelo tiene que encontrar ahora un suceso **más raro** y más relacionado con el alta.

5.4 Separar desarrollo y prueba (error 10)

Corrección. En el original, las variables se elegían, los puntos se calculaban y el resultado se comprobaba **con los mismos datos**. Es como corregir un examen con las respuestas delante: siempre sale bien. Para saber si el scorecard funciona con pacientes nuevos hay que guardar datos que el modelo no vea.

Se hace un **corte temporal**, que es como funcionará en la realidad (se construye con el pasado y se aplica al futuro):

- **Desarrollo:** admisiones hasta el 30 de junio de 2023.
- **Prueba:** admisiones desde el 1 de julio de 2023.

Todas las decisiones (qué variables entran, dónde se corta cada tramo, cuántos puntos vale cada categoría) se toman **solo con desarrollo**.

In [32]:
```
FECHA_CORTE = pd.Timestamp('2023-07-01')

desarrollo = risk[risk['fecha_admision'] < FECHA_CORTE].copy()
prueba = risk[risk['fecha_admision'] >= FECHA_CORTE].copy()

for nombre, parte in [('Desarrollo', desarrollo), ('Prueba', prueba)]:
    print(f"{nombre:11s} {len(parte):6d} admisiones  {parte['fecha_admisi
          f"  tasa de reingreso {parte['genera_reingreso'].mean() * 100:.
```

```
Desarrollo    7793 admisiones  2022-04-01 a 2023-06-30  tasa de reingreso
4.50 %
Prueba        4363 admisiones  2023-07-01 a 2024-02-28  tasa de reingreso
4.42 %
```

6. Selección de variables (`03_Minicubo_y_RSC`)

Hay 50 variables candidatas. El *scorecard* debe ser sencillo, así que se eligen las que más se relacionan con el reingreso:

- **Categóricas y 0/1:** prueba **chi-cuadrado**, que mide si el % de reingreso es distinto entre las categorías de la variable. Cuanto mayor el valor chi², más fuerte la relación.
- **Continuas:** prueba **t de Student**, que mide si la media de la variable es distinta entre los que reingresan y los que no.

Se eliminan antes las variables que no tienen sentido como predictores: los identificadores, las fechas y las columnas auxiliares creadas en el paso 5.

In [33]:
```
eliminar = ['id_admision', 'id_paciente', 'fecha_admision', 'fecha_alta',
            'siguiente_ingreso', 'dias_hasta_siguiente', 'seguimiento_com
risk2 = desarrollo.drop(columns=eliminar)
risk2.info()
```

```
<class 'pandas.DataFrame'>
Index: 7793 entries, 1 to 13764
Data columns (total 52 columns):
 #   Column                       Non-Null Count  Dtype
---  ------                       --------------  -----
 0   edad                         7793 non-null   int64
 1   genero                       7793 non-null   str
 2   rural                        7793 non-null   str
 3   tipo_admision                7793 non-null   str
 4   duracion_estancia            7793 non-null   int64
 5   duracion_estancia_ci         7793 non-null   int64
 6   resultado                    7793 non-null   str
 7   tabaquismo                   7793 non-null   int64
 8   alcohol                      7793 non-null   int64
 9   dm                           7793 non-null   int64
 10  hta                          7793 non-null   int64
 11  eac                          7793 non-null   int64
 12  cardiomiopatia_previa        7793 non-null   int64
 13  erc                          7793 non-null   int64
 14  hb                           7754 non-null   float64
 15  leucocitos                   7742 non-null   float64
 16  plaquetas                    7739 non-null   float64
 17  glucosa                      7331 non-null   float64
 18  urea                         7752 non-null   float64
 19  creatinina                   7750 non-null   float64
 20  bnp                          2344 non-null   float64
 21  enzimas_elevadas             7793 non-null   int64
 22  fe                           6867 non-null   float64
 23  anemia_severa                7793 non-null   int64
 24  anemia                       7793 non-null   int64
 25  angina_estable               7793 non-null   int64
 26  sca                          7793 non-null   int64
 27  iamcest                      7793 non-null   int64
 28  dolor_toracico               7793 non-null   int64
 29  insuficiencia_cardiaca       7793 non-null   int64
 30  icfer                        7793 non-null   int64
 31  icfen                        7793 non-null   int64
 32  valvular_cardiaca            7793 non-null   int64
 33  bavc                         7793 non-null   int64
 34  sse                          7793 non-null   int64
 35  lra                          7793 non-null   int64
 36  acv_infarto                  7793 non-null   int64
 37  acv_hemorragia               7793 non-null   int64
 38  fa                           7793 non-null   int64
 39  tv                           7793 non-null   int64
 40  tsvp                         7793 non-null   int64
 41  cardiopatia_congenita        7793 non-null   int64
 42  itu                          7793 non-null   int64
 43  sincope_neurocardiogenico    7793 non-null   int64
 44  hipotension_ortostatica      7793 non-null   int64
 45  endocarditis_infecciosa      7793 non-null   int64
 46  tvp                          7793 non-null   int64
 47  shock_cardiogenico           7793 non-null   int64
 48  shock                        7793 non-null   int64
 49  embolia_pulmonar             7793 non-null   int64
 50  infeccion_pulmonar           7793 non-null   int64
 51  genera_reingreso             7793 non-null   int64
dtypes: float64(8), int64(40), str(4)
memory usage: 3.2 MB
```

In [34]:
```
descriptivos = risk2.describe().T

# Variables 0/1 (mínimo 0 y máximo 1), sin la propia variable objetivo
cero_uno = [v for v in descriptivos[(descriptivos['min'] == 0) & (descrip

# Variables de texto
texto = [c for c in risk2.columns if not pd.api.types.is_numeric_dtype(ri

categoricas = texto + cero_uno
print(len(categoricas), 'categóricas:', categoricas)
```

```
40 categóricas: ['genero', 'rural', 'tipo_admision', 'resultado', 'tabaqui
smo', 'alcohol', 'dm', 'hta', 'eac', 'cardiomiopatia_previa', 'erc', 'enzi
mas_elevadas', 'anemia_severa', 'anemia', 'angina_estable', 'sca', 'iamces
t', 'dolor_toracico', 'insuficiencia_cardiaca', 'icfer', 'icfen', 'valvula
r_cardiaca', 'bavc', 'sse', 'lra', 'acv_infarto', 'acv_hemorragia', 'fa',
'tv', 'tsvp', 'cardiopatia_congenita', 'itu', 'sincope_neurocardiogenico',
'hipotension_ortostatica', 'endocarditis_infecciosa', 'tvp', 'shock_cardio
genico', 'shock', 'embolia_pulmonar', 'infeccion_pulmonar']
```

Corrección (error 11): el original incluía `genera_reingreso` en la lista de categóricas (también es 0/1), y por eso el primer puesto del ranking era la propia variable objetivo, con un chi² enorme. Se saltaba empezando en `[1:10]`. Aquí se excluye al construir la lista, que es más seguro.

Chi-cuadrado para las categóricas

In [35]:
```
def chi_square_test(df, target_col, categorical_col):
    # Tabla de contingencia (categoría x reingreso) sin los nulos de esa
    df_filtrado = df.dropna(subset=[categorical_col])
    tabla_contingencia = pd.crosstab(df_filtrado[categorical_col], df_fil
    chi2, p, dof, expected = chi2_contingency(tabla_contingencia)
    return chi2, p

resultados = {var: chi_square_test(risk2, 'genera_reingreso', var) for va
ranking = pd.DataFrame(resultados, index=['Chi2', 'P-valor']).T.sort_valu
ranking.head(15)
```

Out[35]:

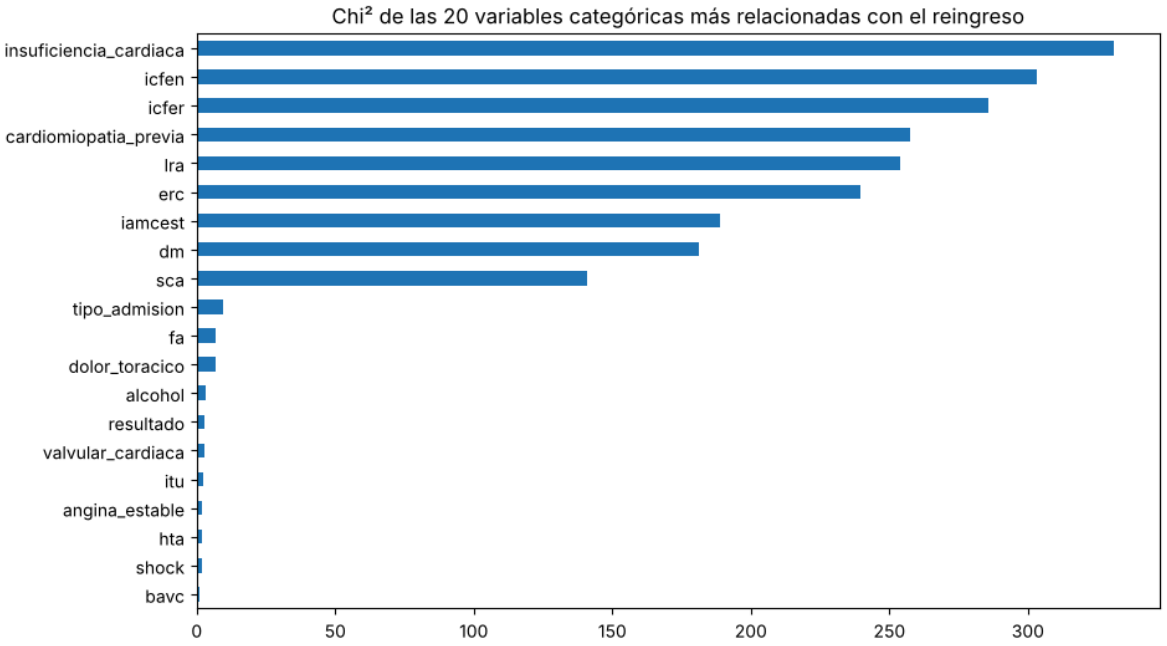
	Chi2	P-valor
insuficiencia_cardiaca	330.935198	6.013133e-74
icfen	303.093381	6.979739e-68
icfer	285.509472	4.731815e-64
cardiomiopatia_previa	257.272312	6.746815e-58
lra	253.867465	3.726686e-57
erc	239.709769	4.549765e-54
iamcest	188.703454	6.100198e-43
dm	181.352770	2.455058e-41
sca	140.795431	1.783507e-32
tipo_admision	9.498503	2.056396e-03
fa	7.058061	7.890936e-03
dolor_toracico	6.773580	9.251705e-03
alcohol	3.120742	7.730157e-02
resultado	2.909174	8.807696e-02
valvular_cardiaca	2.684293	1.013422e-01

In [36]:
```
ranking[ranking['P-valor'] <= 0.01]
```

Out[36]:

	Chi2	P-valor
insuficiencia_cardiaca	330.935198	6.013133e-74
icfen	303.093381	6.979739e-68
icfer	285.509472	4.731815e-64
cardiomiopatia_previa	257.272312	6.746815e-58
lra	253.867465	3.726686e-57
erc	239.709769	4.549765e-54
iamcest	188.703454	6.100198e-43
dm	181.352770	2.455058e-41
sca	140.795431	1.783507e-32
tipo_admision	9.498503	2.056396e-03
fa	7.058061	7.890936e-03
dolor_toracico	6.773580	9.251705e-03

In [37]:
```
ax = ranking['Chi2'].head(20).plot.barh(figsize=(10, 6), title='Chi² de l
ax.invert_yaxis()
plt.show()
```



Hay un **corte muy claro**: 9 variables tienen un chi² entre 140 y 330, y la siguiente cae por debajo de 10. Son las mismas 9 del original (con un orden ligeramente distinto). Se seleccionan esas 9.

In [38]:
```
N_CATEGORICAS = 9
significativas_cat = ranking.index[:N_CATEGORICAS].to_list()
significativas_cat
```

Out[38]:
```
['insuficiencia_cardiaca',
 'icfen',
 'icfer',
 'cardiomiopatia_previa',
 'lra',
 'erc',
 'iamcest',
 'dm',
 'sca']
```

t de Student para las continuas

Mejora: se usa `equal_var=False` (prueba de Welch). La t clásica supone que los dos grupos tienen la misma varianza, y aquí hay muchos menos reingresos que no reingresos. Welch no necesita ese supuesto y es la recomendada por defecto.

In [39]:
```
continuas = [c for c in risk2.columns if c not in categoricas + ['genera_

filas = []
for col in continuas:
    sin_nulos = risk2.dropna(subset=[col])
    grupo_no = sin_nulos.loc[sin_nulos['genera_reingreso'] == 0, col]
    grupo_si = sin_nulos.loc[sin_nulos['genera_reingreso'] == 1, col]
    if len(grupo_no) > 30 and len(grupo_si) > 30:
        t_stat, p_valor = ttest_ind(grupo_no, grupo_si, equal_var=False)
        filas.append({'variable': col, 'media_no_reingresa': grupo_no.mea
                      't': t_stat, 'p_valor': p_valor})

pruebas_t = pd.DataFrame(filas).set_index('variable').sort_values('p_valo
```

```
pruebas_t['diagnostico'] = np.where(pruebas_t['p_valor'] < 0.01, 'Signifi
pruebas_t
```

Out[39]:

variable	media_no_reingresa	media_reingresa	t	p_valor	di
urea	46.328392	58.860399	-4.514092	0.000009	Si
edad	60.614620	63.572650	-4.416467	0.000013	Si
duracion_estancia_ci	3.565171	4.683761	-4.285292	0.000023	Si
duracion_estancia	6.391696	7.997151	-4.108905	0.000049	Si
fe	43.540000	40.283912	4.105258	0.000050	Si
hb	12.445530	12.006838	3.705618	0.000242	Si
creatinina	1.294828	1.523686	-3.302742	0.001049	Si
bnp	802.288579	1108.934167	-2.758791	0.006658	Si
glucosa	162.626375	171.780120	-1.835700	0.067228	si
plaquetas	239.201516	237.857143	0.253453	0.800052	si
leucocitos	11.384721	11.338000	0.167824	0.866805	si

Corrección (error 9). El original decía "nos quedaremos con las 3 continuas más significativas", pero hacía `significativas_con[:3]`: las 3 primeras de la lista, que estaba **en el orden de las columnas** (edad, duracion_estancia, duracion_estancia_ci). Aquí la tabla está ordenada por p-valor, así que las 3 primeras sí son las más significativas.

Lectura: los que reingresan son algo mayores, tienen la urea más alta (peor función renal), más días en cuidados intensivos y la fracción de eyección más baja (el corazón bombea peor). Todo tiene sentido clínico.

In [40]:
```
N_CONTINUAS = 3
significativas_con = pruebas_t[pruebas_t['diagnostico'] == 'Significativa

significativas = significativas_cat + significativas_con
significativas
```

Out[40]:
```
['insuficiencia_cardiaca',
 'icfen',
 'icfer',
 'cardiomiopatia_previa',
 'lra',
 'erc',
 'iamcest',
 'dm',
 'sca',
 'urea',
 'edad',
 'duracion_estancia_ci']
```

7. Minicubo (`03_Minicubo_y_RSC`)

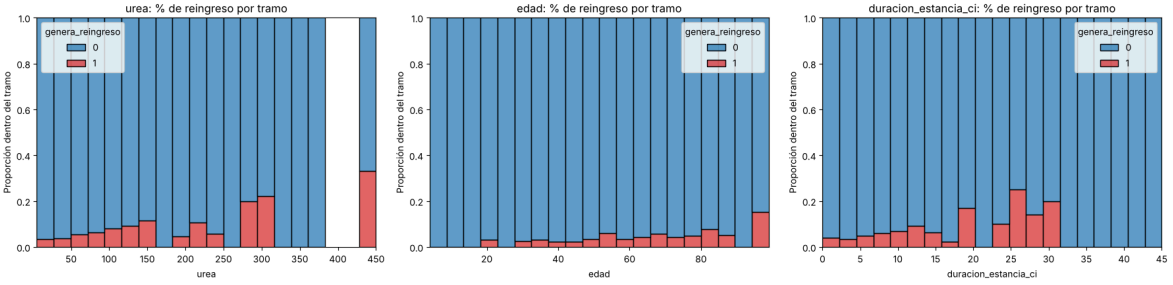
Pasos:

1. Reducir la dimensión a las variables significativas (hecho en el paso 6).
2. Convertir las variables continuas en categóricas (tramos).
3. Pasar a formato transaccional (una fila por admisión y variable).
4. Calcular la penetración del reingreso en cada variable-valor.

7.1 Discretización de las continuas

El original miraba un histograma normalizado (cada barra al 100 %, con el % de reingreso de cada tramo) y elegía los cortes a ojo. Se mantiene el gráfico para entender cada variable:

In [41]:
```
fig, ejes = plt.subplots(1, len(significativas_con), figsize=(18, 4.5))
for eje, variable in zip(ejes, significativas_con):
    sns.histplot(data=risk2, x=variable, hue='genera_reingreso', bins=20,
                 multiple='fill', palette=['tab:blue', 'tab:red'], edgeco
    eje.set_title(f'{variable}: % de reingreso por tramo')
    eje.set_ylabel('Proporción dentro del tramo')
plt.tight_layout()
plt.show()
```



`multiple='fill'` pone todas las barras a la misma altura (100 %). Así no importa cuántos pacientes hay en cada tramo: solo se ve **qué parte** de cada tramo reingresa (en rojo).

Corrección de la leyenda: en el original la leyenda tenía las etiquetas cambiadas (`labels=['% Reingresos', '% No reingresos']`). Seaborn dibuja primero el 0 y después el 1, y forzar las etiquetas a mano las asignaba al revés. Aquí se deja la leyenda que genera Seaborn (0 = no reingresa, 1 = reingresa).

Mejora: cortes por quintiles en lugar de a ojo. Los cortes manuales tienen dos problemas. Dependen de quien mira el gráfico, y algunos tramos se quedan con muy pocos pacientes. Por ejemplo, en el original el tramo de estancia de 60 a 100 días tenía 1 o 2 casos y le daba 100 puntos, el máximo de toda la tabla, por **un solo paciente**. Con **quintiles** (`qcut` en 5 grupos) cada tramo tiene el 20 % de los pacientes de desarrollo, y su % de reingreso es fiable. Los cortes se calculan **solo con desarrollo** y se guardan para aplicarlos tal cual a prueba y a producción.

Los extremos se dejan abiertos (`-inf` e `inf`), para que un valor nuevo más alto o más bajo que todos los de desarrollo caiga en el primer o en el último tramo en lugar de quedar fuera.

In [42]:
```
def calcular_cortes(serie, n_tramos=5):
    # Cortes por cuantiles (sin repetir), con los extremos abiertos
    cortes = np.unique(np.quantile(serie.dropna(), np.linspace(0, 1, n_tr
    return [-np.inf] + list(cortes[1:-1]) + [np.inf]

def tramificar(serie, cortes):
    # Convierte una variable continua en texto con su tramo; los nulos pa
    tramos = pd.cut(serie, bins=cortes).astype(str)
    return tramos.where(serie.notna(), 'Sin dato')

cortes = {variable: calcular_cortes(risk2[variable]) for variable in sign
for variable, c in cortes.items():
    print(f'{variable:22s}', c)
```

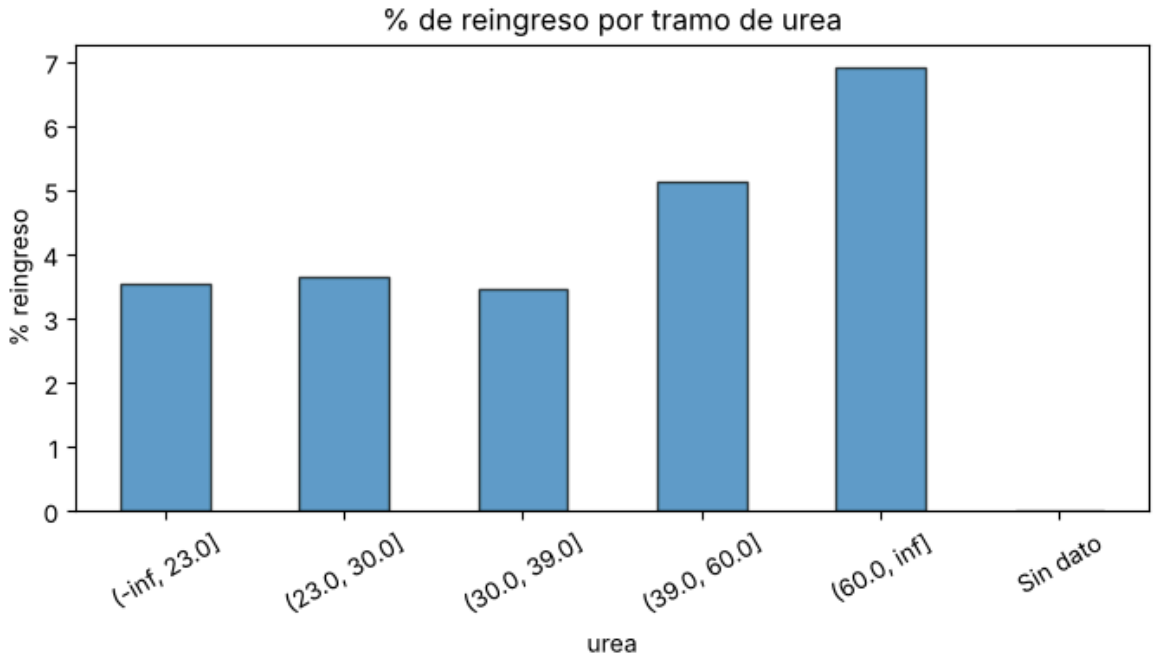
```
urea                   [-inf, np.float64(23.0), np.float64(30.0), np.float
64(39.0), np.float64(60.0), inf]
edad                   [-inf, np.float64(50.0), np.float64(58.0), np.float
64(65.0), np.float64(72.0), inf]
duracion_estancia_ci   [-inf, np.float64(2.0), np.float64(4.0), np.float64
(6.0), inf]
```

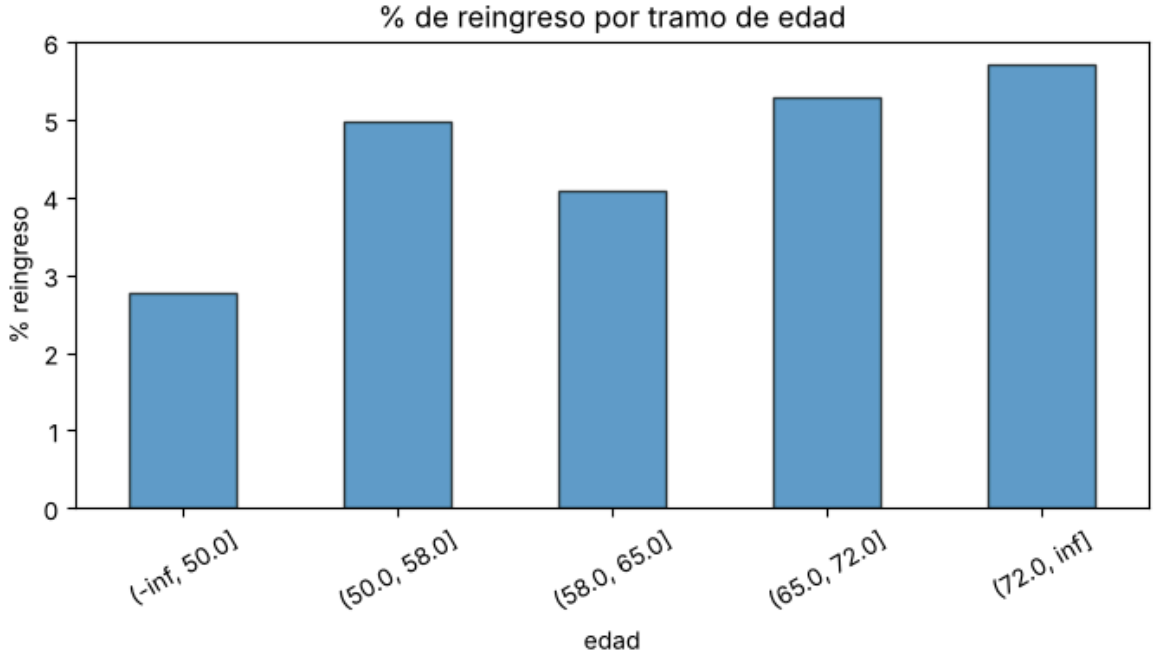
Si una variable tiene muchos valores repetidos, dos cuantiles pueden coincidir (por ejemplo, el 20 % y el 40 % de `duracion_estancia_ci` pueden ser los dos 1 día). `np.unique` elimina los cortes repetidos y la variable se queda con menos tramos.

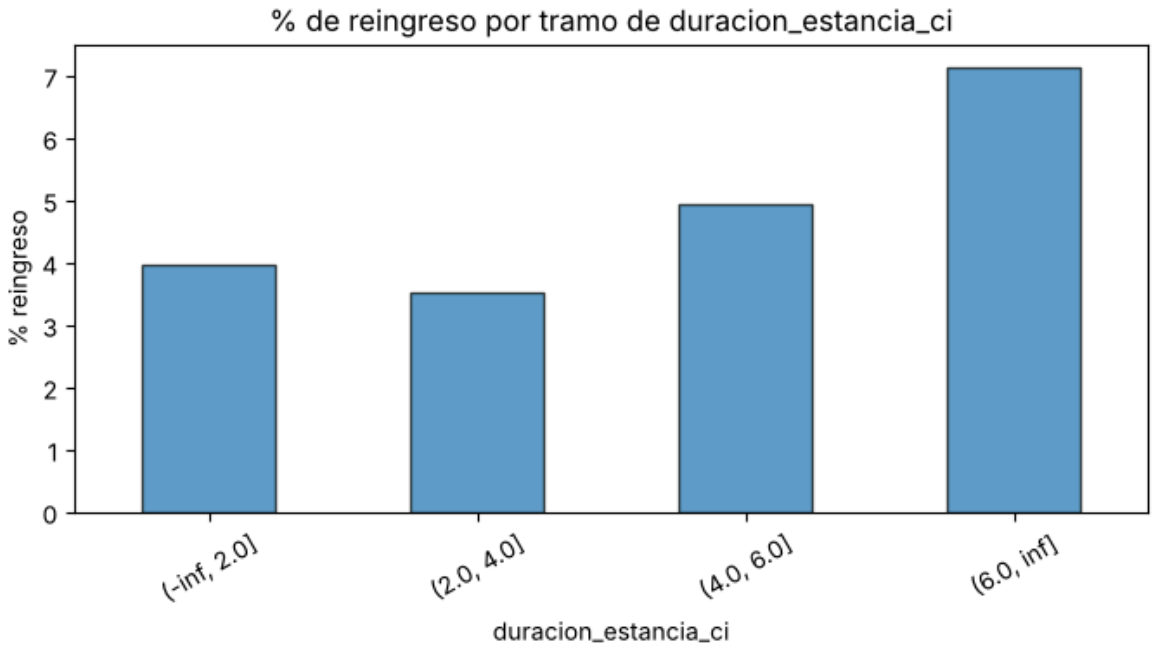
`tramificar` hace dos cosas:

1. `pd.cut(...).astype(str)` convierte el tramo en **texto**, por ejemplo `'(58.0, 65.0]'`. En el original los tramos se quedaban como objetos `Interval`, y por eso la comparación con `"(0, 10]"` de la función de scoring nunca se cumplía (error 6).
2. `where(serie.notna(), 'Sin dato')`: los nulos se convierten en una categoría propia. En un scorecard "no se le hizo la analítica" también puede aportar información.

In [43]:
```
for variable in significativas_con:
    tramo = tramificar(risk2[variable], cortes[variable])
    (risk2.groupby(tramo)['genera_reingreso'].mean() * 100).plot.bar(
        rot=30, edgecolor='k', alpha=0.7, figsize=(8, 3.5), title=f'% de
    plt.ylabel('% reingreso')
    plt.show()
```


% de reingreso por tramo de urea
% reingreso
0
1
2
3
4
5
6
7
(-inf, 23.0]
(23.0, 30.0]
(30.0, 39.0]
(39.0, 60.0]
(60.0, inf]
Sin dato
urea


% de reingreso por tramo de edad
% reingreso
0
1
2
3
4
5
6
(-inf, 50.0]
(50.0, 58.0]
(58.0, 65.0]
(65.0, 72.0]
(72.0, inf]
edad



7.2 Crear el minicubo

Se queda con las variables significativas, se sustituyen las continuas por sus tramos y se pasa a formato **transaccional** con `melt`.

In [44]:
```
def preparar_minicubo(datos):
    # Tabla con las variables del scorecard ya como texto: 0/1 de las cat
    salida = pd.DataFrame(index=datos.index)
    for variable in significativas_cat:
        salida[variable] = datos[variable].astype(str)
    for variable in significativas_con:
        salida[variable] = tramificar(datos[variable], cortes[variable])
    return salida

minicubo = preparar_minicubo(risk2)
minicubo['genera_reingreso'] = risk2['genera_reingreso']
minicubo
```

Out[44]:

	insuficiencia_cardiaca	icfen	icfer	cardiomiopatia_previa	lra	erc	iamcest
1	1	1	0	1	0	1	1
2	1	0	1	0	0	0	0
4	0	1	1	1	1	0	1
7	0	0	0	0	0	0	0
8	0	0	1	0	0	0	0
...	...	...	...	...	...	...	...
13755	1	0	1	1	0	0	0
13756	1	0	1	1	1	1	0
13757	0	1	1	0	1	1	1
13758	0	0	0	0	1	0	1
13764	1	0	0	0	0	1	1

7793 rows × 13 columns

In [45]:
```
# Pasamos a formato transaccional: una fila por admisión y variable
minicubo = minicubo.melt(id_vars='genera_reingreso')
minicubo
```

Out[45]:

	genera_reingreso	variable	value
0	0	insuficiencia_cardiaca	1
1	0	insuficiencia_cardiaca	1
2	0	insuficiencia_cardiaca	0
3	0	insuficiencia_cardiaca	0
4	0	insuficiencia_cardiaca	0
...	...	...	...
93511	0	duracion_estancia_ci	(4.0, 6.0]
93512	0	duracion_estancia_ci	(4.0, 6.0]
93513	0	duracion_estancia_ci	(-inf, 2.0]
93514	0	duracion_estancia_ci	(-inf, 2.0]
93515	0	duracion_estancia_ci	(-inf, 2.0]

93516 rows × 3 columns

`melt` pasa de **ancho** (una columna por variable) a **largo** (una fila por admisión y variable, con las columnas `variable` y `value`). Así se puede calcular la penetración de todas las variables de una vez con un solo `groupby`.

En el original, después del `melt` había que convertir `value` a texto, porque mezclaba números (0/1) con intervalos. Aquí ya es todo texto desde `preparar_minicubo`.

In [46]:
```
# Penetración del reingreso en cada variable-valor
minicubo = minicubo.groupby(['variable', 'value']).agg(
    admisiones=('genera_reingreso', 'size'),
    genera_reingreso=('genera_reingreso', 'mean'),
).reset_index()
minicubo
```

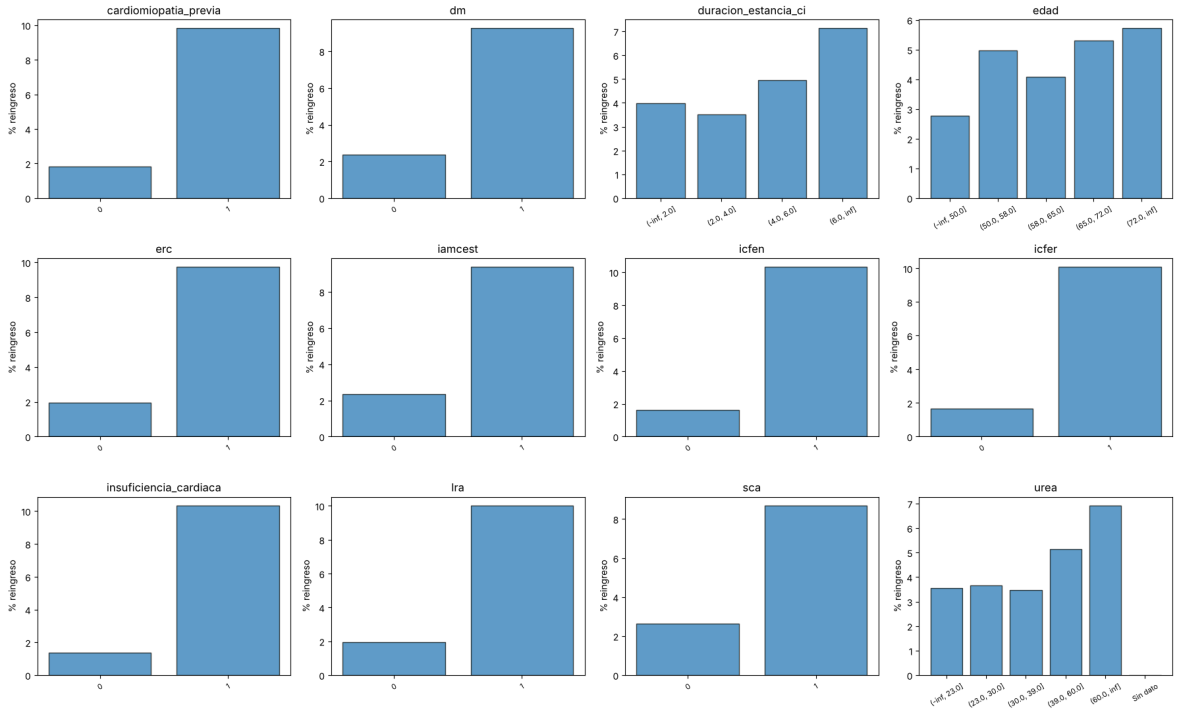
Out[46]:

	variable	value	admisiones	genera_reingreso
0	cardiomiopatia_previa	0	5177	0.018157
1	cardiomiopatia_previa	1	2616	0.098242
2	dm	0	5383	0.023779
3	dm	1	2410	0.092531
4	duracion_estancia_ci	(-inf, 2.0]	3703	0.039698
5	duracion_estancia_ci	(2.0, 4.0]	1704	0.035211
6	duracion_estancia_ci	(4.0, 6.0]	1194	0.049414
7	duracion_estancia_ci	(6.0, inf]	1192	0.071309
8	edad	(-inf, 50.0]	1586	0.027743
9	edad	(50.0, 58.0]	1547	0.049774
10	edad	(58.0, 65.0]	1882	0.040914
11	edad	(65.0, 72.0]	1397	0.052971
12	edad	(72.0, inf]	1381	0.057205
13	erc	0	5249	0.019623
14	erc	1	2544	0.097484
15	iamcest	0	5405	0.023497
16	iamcest	1	2388	0.093802
17	icfen	0	5208	0.016129
18	icfen	1	2585	0.103288
19	icfer	0	5167	0.016644
20	icfer	1	2626	0.100914
21	insuficiencia_cardiaca	0	5069	0.013612
22	insuficiencia_cardiaca	1	2724	0.103524
23	lra	0	5331	0.019509
24	lra	1	2462	0.100325
25	sca	0	5391	0.026340
26	sca	1	2402	0.087011
27	urea	(-inf, 23.0]	1635	0.035474
28	urea	(23.0, 30.0]	1640	0.036585
29	urea	(30.0, 39.0]	1474	0.034600
30	urea	(39.0, 60.0]	1458	0.051440
31	urea	(60.0, inf]	1545	0.069256
32	urea	Sin dato	41	0.000000

`genera_reingreso` es ahora la **penetración**: la proporción de admisiones de esa categoría que reingresan. Por ejemplo, si con `insuficiencia_cardiaca = 1` vale 0,10, el 10 % de las admisiones con insuficiencia cardiaca reingresa en 30 días.

Mejora: se añade la columna `admisiones`, para ver en qué categorías hay pocos casos y su penetración es menos fiable.

In [47]:
```
variables_minicubo = minicubo['variable'].unique()
fig, ejes = plt.subplots(3, 4, figsize=(18, 11))
for eje, variable in zip(ejes.flat, variables_minicubo):
    subset = minicubo[minicubo['variable'] == variable]
    eje.bar(subset['value'], subset['genera_reingreso'] * 100, edgecolor=
    eje.set_title(variable)
    eje.set_ylabel('% reingreso')
    eje.tick_params(axis='x', rotation=30, labelsize=8)
for eje in list(ejes.flat)[len(variables_minicubo):]:
    eje.axis('off')
plt.tight_layout()
plt.show()
```



Mejora: los 12 gráficos se dibujan en una cuadrícula, para compararlos de un vistazo.

En los 9 diagnósticos, tener el diagnóstico (1) multiplica por 4 o 5 el % de reingreso frente a no tenerlo (0). En las continuas, el riesgo crece en general con la urea, la edad y los días en CI, aunque no de forma perfectamente escalonada. En `urea`, la categoría "Sin dato" (las pocas admisiones sin ese análisis) no tiene ningún reingreso y vale 0 puntos.

7.3 Corrección (error 12): diagnósticos que se solapan

In [48]:
```
ic = ['insuficiencia_cardiaca', 'icfer', 'icfen']
print('Correlación entre los tres diagnósticos de insuficiencia cardiaca:
print(desarrollo[ic].corr().round(2))
print('\nAdmisiones con IC que tienen también ICFEr o ICFEn:',
      f"{((desarrollo['insuficiencia_cardiaca'] == 1) & ((desarrollo['icf
```

```
Correlación entre los tres diagnósticos de insuficiencia cardiaca:
                       insuficiencia_cardiaca  icfer  icfen
insuficiencia_cardiaca                    1.00   0.29   0.28
icfer                                     0.29   1.00   0.27
icfen                                     0.28   0.27   1.00

Admisiones con IC que tienen también ICFEr o ICFEn: 24.0 %
```

El *scorecard* suma los puntos de cada variable como si fueran independientes. Clínicamente, la ICFEr y la ICFEn son los dos tipos de insuficiencia cardiaca, así que en datos reales estas tres columnas irían juntas, y un paciente con IC sumaría puntos **dos o tres veces por la misma enfermedad**.

En estos datos no pasa: la correlación entre ellas es de solo 0,28 y solo el 24 % de las admisiones con IC tiene también ICFEr o ICFEn. Se comportan como variables casi independientes, lo que vuelve a apuntar a datos sintéticos. El doble conteo aquí es pequeño.

Es una **limitación del método** que hay que tener presente: con datos reales, los modelos que tienen en cuenta la relación entre variables, como la regresión logística (la base de los scorecards de riesgo de crédito), reparten el peso entre ellas en lugar de sumarlo varias veces.

8. Risk Score Card (`03_Minicubo_y_RSC`)

8.1 Tabla de puntos

Los puntos de cada categoría son su penetración × 100, es decir, su % de reingreso.

Corrección (error 8): el original hacía `(penetración * 100).astype('int')`, y `astype('int')` **trunca** (8,88 pasa a 8). Aquí se redondea a 1 decimal.

In [49]:
```
rsc = minicubo.copy()
rsc['puntos'] = (rsc['genera_reingreso'] * 100).round(1)
rsc
```

Out[49]:

	variable	value	admisiones	genera_reingreso	puntos
0	cardiomiopatia_previa	0	5177	0.018157	1.8
1	cardiomiopatia_previa	1	2616	0.098242	9.8
2	dm	0	5383	0.023779	2.4
3	dm	1	2410	0.092531	9.3
4	duracion_estancia_ci	(-inf, 2.0]	3703	0.039698	4.0
5	duracion_estancia_ci	(2.0, 4.0]	1704	0.035211	3.5
6	duracion_estancia_ci	(4.0, 6.0]	1194	0.049414	4.9
7	duracion_estancia_ci	(6.0, inf]	1192	0.071309	7.1
8	edad	(-inf, 50.0]	1586	0.027743	2.8
9	edad	(50.0, 58.0]	1547	0.049774	5.0
10	edad	(58.0, 65.0]	1882	0.040914	4.1
11	edad	(65.0, 72.0]	1397	0.052971	5.3
12	edad	(72.0, inf]	1381	0.057205	5.7
13	erc	0	5249	0.019623	2.0
14	erc	1	2544	0.097484	9.7
15	iamcest	0	5405	0.023497	2.3
16	iamcest	1	2388	0.093802	9.4
17	icfen	0	5208	0.016129	1.6
18	icfen	1	2585	0.103288	10.3
19	icfer	0	5167	0.016644	1.7
20	icfer	1	2626	0.100914	10.1
21	insuficiencia_cardiaca	0	5069	0.013612	1.4
22	insuficiencia_cardiaca	1	2724	0.103524	10.4
23	lra	0	5331	0.019509	2.0
24	lra	1	2462	0.100325	10.0
25	sca	0	5391	0.026340	2.6
26	sca	1	2402	0.087011	8.7
27	urea	(-inf, 23.0]	1635	0.035474	3.5
28	urea	(23.0, 30.0]	1640	0.036585	3.7
29	urea	(30.0, 39.0]	1474	0.034600	3.5
30	urea	(39.0, 60.0]	1458	0.051440	5.1
31	urea	(60.0, inf]	1545	0.069256	6.9
32	urea	Sin dato	41	0.000000	0.0

Corrección (error 13): en el original, la celda `rsc['puntos'] = ...` se había ejecutado cuando `minicubo` todavía era la tabla ancha (una fila por admisión). Por eso la salida guardada no es una tabla de puntos. Aquí `rsc` sale del minicubo ya agregado.

8.2 Función de scoring

Corrección (errores 6 y 14). El original pidió a la IA una función con reglas si-entonces escritas a mano (`if registro.get("dm") == 1: scoring += 49` ...). Tenía tres problemas:

1. **Nunca sumaba los puntos de edad ni de las estancias**, porque preguntaba por las columnas `edad_disc`, `duracion_estancia_disc` y `duracion_estancia_ci_disc`, que no existían en `risk`. Prueba: el rango que salía, de 84 a 457, es exactamente la suma de los puntos mínimos y máximos de las 9 binarias (8+11+10+12+8+7+6+10+12 = 84 y 52+49+51+47+53+54+54+50+47 = 457).
2. Si cambian los datos, hay que reescribir la función a mano, y un número mal copiado no se detecta.
3. Aplicada fila a fila con `apply`, es lenta.

Aquí los puntos se buscan en la tabla `rsc`, y la propia función se encarga de discretizar las continuas con los cortes guardados:

In [50]:
```
# Diccionario {variable: {valor: puntos}} a partir de la tabla rsc
tabla_puntos = {variable: grupo.set_index('value')['puntos'].to_dict() fo

def calcular_scoring(datos, tabla_puntos, cortes):
    # Suma los puntos de cada variable del scorecard para todas las filas
    preparados = pd.DataFrame(index=datos.index)
    for variable in tabla_puntos:
        if variable in cortes:
            valores = tramificar(datos[variable], cortes[variable])
        else:
            valores = datos[variable].astype(str)
        # Una categoría que no estaba en desarrollo recibe los puntos más
        preparados[variable] = valores.map(tabla_puntos[variable]).fillna
    return preparados.sum(axis=1)

desarrollo['scoring_puntos'] = calcular_scoring(desarrollo, tabla_puntos,
prueba['scoring_puntos'] = calcular_scoring(prueba, tabla_puntos, cortes)

desarrollo.groupby('genera_reingreso')['scoring_puntos'].mean()
```

Out[50]:
```
genera_reingreso
0    52.777466
1    81.941880
Name: scoring_puntos, dtype: float64
```

La función trabaja con **toda la tabla a la vez** (`.map` sobre columnas), sin recorrer fila a fila, y lee los puntos de la tabla en lugar de llevarlos copiados. Si mañana se recalcula el scorecard con datos nuevos, la función no cambia.

Los pacientes que reingresan tienen, de media, una puntuación claramente más alta.

8.3 Cambio de escala a 0-10

Corrección (error 7). El texto original decía "el mínimo y el máximo que se puede conseguir con nuestra tabla de puntuaciones", pero el código usaba `risk['scoring'].min()` y `.max()`, que son el mínimo y el máximo **de los pacientes de esa tabla**. En producción eso es un problema: cada ejecución tiene otros pacientes, otros mínimos y máximos, y el mismo paciente podría sacar un 6 un día y un 7 al siguiente.

El mínimo y el máximo **teóricos** salen de la tabla de puntos: el paciente con menos riesgo posible tiene el valor más bajo de cada variable, y el de más riesgo, el más alto. Son fijos.

In [51]:
```
PUNTOS_MIN = sum(min(puntos.values()) for puntos in tabla_puntos.values()
PUNTOS_MAX = sum(max(puntos.values()) for puntos in tabla_puntos.values()
print(f'Rango teórico de puntos: {PUNTOS_MIN:.1f} a {PUNTOS_MAX:.1f}')

def escalar_0_10(puntos):
    # Reescala los puntos a 0-10 con el rango teórico y redondea (el orig
    return ((puntos - PUNTOS_MIN) / (PUNTOS_MAX - PUNTOS_MIN) * 10).round

desarrollo['scoring'] = escalar_0_10(desarrollo['scoring_puntos'])
prueba['scoring'] = escalar_0_10(prueba['scoring_puntos'])

desarrollo['scoring'].value_counts().sort_index()
```

```
Rango teórico de puntos: 24.1 a 107.4
```

Out[51]:
```
scoring
0       92
1      970
2     1952
3     1701
4      878
5      498
6      467
7      606
8      450
9      158
10      21
Name: count, dtype: int64
```

`.clip(0, 10)` es una protección: no debería pasar, pero si una categoría nueva sacara de rango a algún paciente, se queda en 0 o en 10.

8.4 Guardar el scorecard

Mejora. El script de producción no debe recalcular el scorecard: debe **usar** el que se ha construido aquí. El original lo resolvía pegando la función con los números escritos a mano. Aquí se guarda todo lo necesario en un archivo JSON (puntos, cortes y rango) y producción lo lee.

Así hay una única fuente de verdad: si se recalcula el scorecard, se regenera el archivo y producción lo usa sin tocar su código.

In [52]:
```
RUTA_SCORECARD = Path('scorecard_reingresos.json')

scorecard = {
    'ventana_dias': VENTANA_DIAS,
    'fecha_corte_desarrollo': str(FECHA_CORTE.date()),
    'puntos': tabla_puntos,
    # JSON no admite infinito: se guardan solo los cortes intermedios
    'cortes': {variable: c[1:-1] for variable, c in cortes.items()},
    'puntos_min': PUNTOS_MIN,
    'puntos_max': PUNTOS_MAX,
}
RUTA_SCORECARD.write_text(json.dumps(scorecard, indent=2, ensure_ascii=Fa
print(RUTA_SCORECARD.read_text())
```

```
{
  "ventana_dias": 30,
  "fecha_corte_desarrollo": "2023-07-01",
  "puntos": {
    "cardiomiopatia_previa": {
      "0": 1.8,
      "1": 9.8
    },
    "dm": {
      "0": 2.4,
      "1": 9.3
    },
    "duracion_estancia_ci": {
      "(-inf, 2.0]": 4.0,
      "(2.0, 4.0]": 3.5,
      "(4.0, 6.0]": 4.9,
      "(6.0, inf]": 7.1
    },
    "edad": {
      "(-inf, 50.0]": 2.8,
      "(50.0, 58.0]": 5.0,
      "(58.0, 65.0]": 4.1,
      "(65.0, 72.0]": 5.3,
      "(72.0, inf]": 5.7
    },
    "erc": {
      "0": 2.0,
      "1": 9.7
    },
    "iamcest": {
      "0": 2.3,
      "1": 9.4
    },
    "icfen": {
      "0": 1.6,
      "1": 10.3
    },
    "icfer": {
      "0": 1.7,
      "1": 10.1
    },
    "insuficiencia_cardiaca": {
      "0": 1.4,
      "1": 10.4
    },
    "lra": {
      "0": 2.0,
      "1": 10.0
    },
    "sca": {
      "0": 2.6,
      "1": 8.7
    },
    "urea": {
      "(-inf, 23.0]": 3.5,
      "(23.0, 30.0]": 3.7,
      "(30.0, 39.0]": 3.5,
      "(39.0, 60.0]": 5.1,
      "(60.0, inf]": 6.9,
      "Sin dato": 0.0
```

```
    }
  },
  "cortes": {
    "urea": [
      23.0,
      30.0,
      39.0,
      60.0
    ],
    "edad": [
      50.0,
      58.0,
      65.0,
      72.0
    ],
    "duracion_estancia_ci": [
      2.0,
      4.0,
      6.0
    ]
  },
  "puntos_min": 24.1,
  "puntos_max": 107.4
}
```


9. Validación (error 10)

Mejora. El original comprobaba que los que reingresaban tenían más puntos de media, pero con los mismos datos con los que se había construido el scorecard. Aquí se mide en el periodo de **prueba**, con pacientes que el scorecard no ha visto.

La medida estándar es el **AUC** (*Area Under the ROC Curve*): la probabilidad de que, cogiendo al azar un paciente que reingresa y otro que no, el que reingresa tenga más puntos.

AUC	Lectura
0,5	Como tirar una moneda: el scorecard no sirve
0,7-0,8	Aceptable
0,8-0,9	Bueno
más de 0,9	Excelente (y conviene sospechar si los datos son reales)

In [53]:
```
auc_desarrollo = roc_auc_score(desarrollo['genera_reingreso'], desarrollo
auc_prueba = roc_auc_score(prueba['genera_reingreso'], prueba['scoring_pu
print(f'AUC en desarrollo: {auc_desarrollo:.3f}')
print(f'AUC en prueba:     {auc_prueba:.3f}')
```

```
AUC en desarrollo: 0.892
AUC en prueba:     0.892
```

El AUC en prueba es prácticamente igual que en desarrollo: el scorecard **no está sobreajustado** y funciona igual de bien con pacientes nuevos. Un AUC cercano a 0,9 es muy alto para un modelo de reingresos (en estudios con datos reales se

suele estar entre 0,65 y 0,75). Es otra señal de que los datos son sintéticos y la relación entre diagnósticos y reingreso es más limpia que en la realidad.

¿Qué aportan las correcciones? Se compara el scorecard original (con sus puntos y su error de edad y estancias) con el corregido, en el periodo de prueba y con el reingreso a 30 días:

In [54]:
```
# Puntos del scorecard original: solo las 9 binarias, como pasaba por el
puntos_originales = {'cardiomiopatia_previa': (8, 52), 'dm': (11, 49), 'e
                     'icfen': (8, 53), 'icfer': (7, 54), 'insuficiencia_c
scoring_original = sum(np.where(prueba[v] == 1, si, no) for v, (no, si) i

print(f"AUC del scorecard original en prueba:  {roc_auc_score(prueba['gen
print(f"AUC del scorecard corregido en prueba: {auc_prueba:.3f}")
```

```
AUC del scorecard original en prueba:  0.891
AUC del scorecard corregido en prueba: 0.892
```

Los dos ordenan a los pacientes prácticamente igual de bien. Esto quiere decir que **el método del original funcionaba**: los 9 diagnósticos llevan casi toda la información, y por eso olvidar la edad y las estancias apenas se nota. Lo que cambia con las correcciones es:

1. **La fiabilidad de lo que se afirma.** El original no medía el rendimiento con datos nuevos; ahora sí se sabe que funciona.
2. **El significado de la nota.** El objetivo es el reingreso a 30 días, sin duplicados ni censura.
3. **La estabilidad en producción.** La escala es fija y la función usa todas las variables.

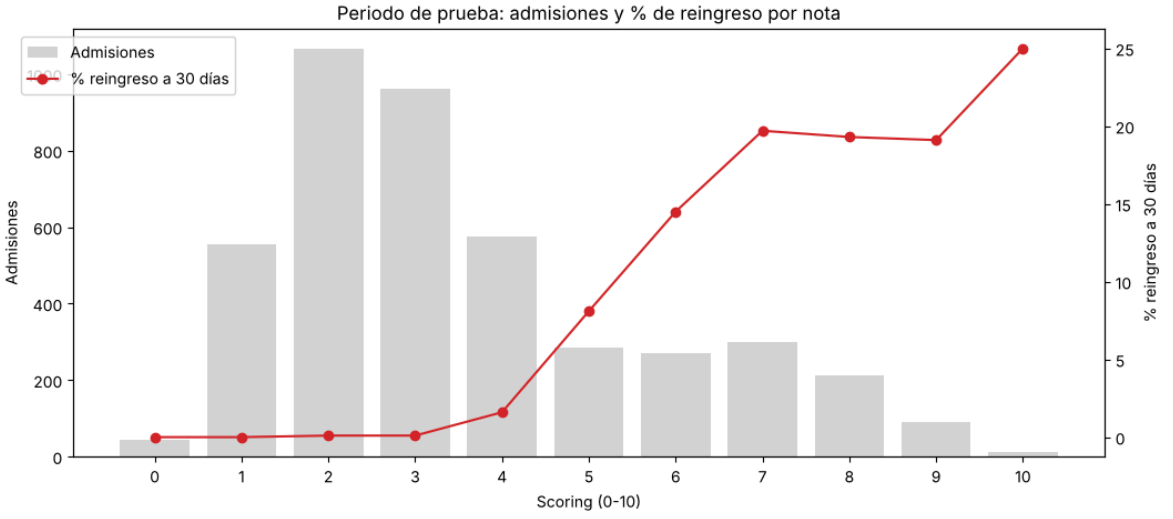
9.1 ¿La nota de 0 a 10 ordena el riesgo?

In [55]:
```
validacion = prueba.groupby('scoring').agg(admisiones=('genera_reingreso'
                                           reingresos=('genera_reingreso'
                                           tasa_reingreso=('genera_reingr
validacion['tasa_reingreso_%'] = (validacion.pop('tasa_reingreso') * 100)
validacion
```

Out[55]:

scoring	admisiones	reingresos	tasa_reingreso_%
0	43	0	0.0
1	554	0	0.0
2	1065	1	0.1
3	961	1	0.1
4	574	9	1.6
5	285	23	8.1
6	269	39	14.5
7	299	59	19.7
8	212	41	19.3
9	89	17	19.1
10	12	3	25.0

In [56]:
```
fig, eje1 = plt.subplots(figsize=(12, 5))
eje1.bar(validacion.index, validacion['admisiones'], color='lightgrey', l
eje1.set_xlabel('Scoring (0-10)')
eje1.set_ylabel('Admisiones')
eje1.set_xticks(range(11))
eje2 = eje1.twinx()
eje2.plot(validacion.index, validacion['tasa_reingreso_%'], color='tab:re
eje2.set_ylabel('% reingreso a 30 días')
eje1.set_title('Periodo de prueba: admisiones y % de reingreso por nota')
fig.legend(loc='upper left', bbox_to_anchor=(0.08, 0.88))
plt.show()
```



El gráfico del original (media de `genera_reingreso` por nota) se mantiene, ahora en el periodo de prueba y con el número de admisiones de cada nota.

Lectura:

- Con nota 3 o menos, el reingreso a 30 días es prácticamente nulo (2 de 2.623 altas); con 4, del 1,6 %.

- A partir de 5 sube con fuerza (8 % en el 5, 15 % en el 6) y se estabiliza en torno al 19-20 % del 7 al 9.
- Las notas más altas tienen pocos pacientes, así que su porcentaje es menos estable.

Uso práctico: un **umbral en 5** separa a los pacientes en los que concentrar el seguimiento al alta (llamada a los pocos días, cita temprana en consulta). Ese grupo es una cuarta parte de las altas y acumula casi todos los reingresos:

In [57]:
```
UMBRAL = 5
alto_riesgo = prueba['scoring'] >= UMBRAL
print(f'Altas con nota >= {UMBRAL}: {alto_riesgo.mean() * 100:.1f} % de l
print(f"Reingresos que se producen en ese grupo: {prueba.loc[alto_riesgo,
```

```
Altas con nota >= 5: 26.7 % de las altas
Reingresos que se producen en ese grupo: 94.3 %
```

10. Producción (`Produccion.ipynb`)

El script de producción se ejecuta con la frecuencia que se programe y:

1. Accede a las fuentes originales de datos.
2. Aplica toda la limpieza y las transformaciones necesarias.
3. Calcula el risk score de cada admisión.
4. Escribe en el datamart la información limpia y enriquecida.

Debe ser limpio (se exportará a un `.py`): sin gráficos, sin salidas de exploración y sin Markdown, solo comentarios con `#`. Y **no crea recursos, los usa**: el scorecard ya está construido y producción solo lo aplica.

Correcciones respecto al `Produccion.ipynb` original:

- La contraseña no está en el código (error 1).
- Se eliminan los episodios duplicados y se desempata el orden (errores 3 y 15).
- El scorecard se lee del archivo JSON, con todas sus variables (errores 6 y 14).
- La escala es fija (errores 7 y 8): la nota de un paciente no depende de los demás pacientes de la carga.
- Además de `reingreso` (¿es esta admisión un reingreso?), se escribe `reingreso_30d` (¿lo es dentro de los 30 días del alta anterior?), para que el dashboard pueda mostrar los dos indicadores.

Aquí se escribe como **una función**. Así se puede probar en el notebook y llamarla desde un `.py` programado.

In [58]:
```
def ejecutar_produccion(url_bd, ruta_scorecard, tabla_salida='tablon_scor
    # Lee las tablas, limpia, calcula el scoring con el scorecard guardad
    motor = create_engine(url_bd)

    # Recurso ya creado: el scorecard (los cortes se guardaron sin los ex
    rsc_prod = json.loads(Path(ruta_scorecard).read_text())
    cortes_prod = {v: [-np.inf] + c + [np.inf] for v, c in rsc_prod['cort
```

```
    # Carga de los datos
    with motor.connect() as conexion:
        tablas = {nombre: pd.read_sql(f'SELECT * FROM {nombre}', conexion
                  ['admisiones', 'diagnosticos', 'factores_riesgo', 'paci
    for columna in ['fecha_admision', 'fecha_alta']:
        tablas['admisiones'][columna] = pd.to_datetime(tablas['admisiones

    # Integración
    datos = (tablas['pacientes']
             .merge(tablas['admisiones'].drop(columns=['id_paciente']), o
             .merge(tablas['factores_riesgo'], on=['id_admision', 'id_pac
             .merge(tablas['pruebas_laboratorio'], on='id_admision', how=
             .merge(tablas['diagnosticos'], on='id_admision', how='left')

    # Limpieza
    datos.loc[datos['duracion_estancia_ci'] > datos['duracion_estancia'],
    datos = datos.sort_values(['id_paciente', 'fecha_admision', 'id_admis
    datos = datos.drop_duplicates(['id_paciente', 'fecha_admision', 'fech

    # Indicadores de reingreso (mirando hacia atrás: solo usan informació
    datos['reingreso'] = (datos['id_paciente'] == datos['id_paciente'].sh
    dias_desde_alta_anterior = (datos['fecha_admision'] - datos.groupby('
    datos['dias_desde_alta_anterior'] = dias_desde_alta_anterior
    datos['reingreso_30d'] = ((dias_desde_alta_anterior >= 0) & (dias_des

    # Indicador histórico SOLO para el dashboard (mira hacia delante; el
    # ¿esta alta acabó en un reingreso a 30 días? Permite mostrar la mism
    datos['dias_hasta_siguiente_ingreso'] = (datos.groupby('id_paciente')
    datos['genera_reingreso_30d'] = datos['dias_hasta_siguiente_ingreso']
    # Altas con 30 días de seguimiento: de las más recientes aún no se sa
    datos['seguimiento_completo'] = (datos['fecha_alta'] <= datos['fecha_

    # Scoring con la tabla de puntos guardada y escala fija
    puntos = calcular_scoring(datos, rsc_prod['puntos'], cortes_prod)
    datos['scoring_puntos'] = puntos
    datos['scoring'] = (((puntos - rsc_prod['puntos_min']) / (rsc_prod['p
                        .round().clip(0, 10).astype(int))

    # Escritura en el datamart
    datos.to_sql(tabla_salida, con=motor, if_exists='replace', index=Fals
    motor.dispose()
    return datos
```

Diferencia entre las dos columnas de reingreso que escribe producción y la variable objetivo del modelo:

- `reingreso` y `reingreso_30d` miran **hacia atrás**: ¿esta admisión es un reingreso? Se pueden calcular en el momento en que el paciente ingresa. Son los indicadores del dashboard.
- `genera_reingreso` (el objetivo del modelo) mira **hacia delante**: ¿esta alta acabará en reingreso? Eso solo se sabe 30 días después. Por eso producción no lo calcula: es justo lo que el scoring intenta anticipar. Es la regla del enunciado de "no incluir información del futuro".
- `genera_reingreso_30d` es esa misma pregunta, pero sobre altas **ya pasadas**: se escribe solo para que el dashboard muestre la tasa de reingreso a

30 días del análisis (4,48 %), junto con `seguimiento_completo` para excluir las altas de los últimos 30 días. El scoring no usa ninguna de las dos, así que la regla de no usar información del futuro se sigue cumpliendo.

Se prueba la función. Escribe `tablon_scoring` en la base de datos a la que apunta `URL_BD`:

In [59]:
```
tablon = ejecutar_produccion(URL_BD, RUTA_SCORECARD)

print('Filas escritas:', len(tablon))
print(tablon[['id_admision', 'id_paciente', 'fecha_admision', 'reingreso'

# Comprobación: la tasa del dashboard coincide con la del análisis
evaluables = tablon[(tablon['resultado'] != 'Defuncion') & (tablon['segui
print(f"Tasa de reingreso a 30 días en el tablón: {evaluables['genera_rei
      f"({evaluables['genera_reingreso_30d'].sum()} de {len(evaluables)}

# Comprobaciones: producción da la misma nota que desarrollo para las mis
comparar = prueba[['id_admision', 'scoring']].merge(tablon[['id_admision'
print('\nAdmisiones de prueba con nota distinta en producción:', (compara

with engine.connect() as conexion:
    print('Filas en tablon_scoring (releído de la base de datos):', pd.re
```

```
Filas escritas: 13767
       id_admision  id_paciente fecha_admision  reingreso  reingreso_30d
scoring_puntos  scoring
14573        15196          506     2024-03-07          0              0
77.9        6
77              93          798     2022-04-05          0              0
78.0        6
3476          3526          798     2022-05-10          1              0
48.0        3
14521        15111          798     2024-03-04          1              0
39.2        2
12549        12720          989     2023-05-12          0              0
84.9        7
Tasa de reingreso a 30 días en el tablón: 4.48 % (544 de 12156 altas)

Admisiones de prueba con nota distinta en producción: 0
Filas en tablon_scoring (releído de la base de datos): 13767
```

Producción da exactamente la misma nota que el desarrollo para las mismas admisiones, y la tabla queda escrita en la base de datos.

Para programarlo, el `.py` solo tendría que hacer:

```
import os
URL_BD = os.environ['URL_BD_CARDIOLOGIA']   # configurada en el
servidor, nunca en el código
ejecutar_produccion(URL_BD, 'scorecard_reingresos.json')
```

Corrección (error 17): se elimina la celda `import sys; print(sys.executable)`, que mostraba la ruta del entorno de Anaconda con tu usuario de Windows.

Resumen

Lo que dicen los datos

Pregunta	Respuesta
¿Cuántos datos hay?	15.038 admisiones de 11.796 pacientes (abril 2022 - marzo 2024), que son 13.767 episodios reales tras quitar duplicados
¿Problemas de calidad?	1.238 episodios duplicados, 24 pacientes con dos géneros, 90 ingresos solapados, 2 fallecidos que reingresan e incoherencias entre los diagnósticos de IC
¿Cuántos reingresos?	23,1 % con la definición original; **4,5 % a 30 días** sin duplicados ni censura
¿Qué variables influyen?	9 diagnósticos (IC, ICFEr, ICFEn, cardiomiopatía, LRA, ERC, IAMCEST, DM, SCA), muy por encima del resto, más urea, edad y días en CI
¿Funciona el scorecard?	AUC ≈ 0,89 con pacientes que no ha visto. Con nota ≥ 5 están una cuarta parte de las altas y casi todos los reingresos

Glosario rápido

Concepto	Qué es
Reingreso a 30 días	Nuevo ingreso del mismo paciente en los 30 días siguientes al alta
Censura por la derecha	Casos cuyo final aún no se conoce porque los datos terminan antes
Penetración	% de casos con el suceso (reingreso) dentro de una categoría
Chi-cuadrado	Prueba de si una variable categórica y el objetivo están relacionados
t de Welch	Prueba de si la media de una variable difiere entre dos grupos, sin suponer varianzas iguales
Minicubo	Tabla variable-valor-penetración a partir de la que se asignan los puntos
AUC	Probabilidad de que un caso positivo tenga más puntos que uno negativo (0,5 = azar, 1 = perfecto)
Desarrollo / prueba	Datos para construir el modelo / datos reservados para comprobar que funciona
`groupby().shift()`	Desplaza una columna dentro de cada grupo (fila anterior o siguiente del mismo paciente)
`melt`	Pasa una tabla de formato ancho a largo